

Buku Referensi
**PENTINGNYA KEBUGARAN FISIK
PADA LANSIA**

Fatimah • Gina Fazrina • Nunuk Sri Purwanti
Jacoba Nugrahaningtyas Wahjuning Utami
Destria Efliani

BUKU REFERENSI PENTINGNYA KEBUGARAN FISIK PADA LANSIA

Fatimah, S.Kp., M.Kep., Ns., Sp.Kep.Kom.

Gina Fazrina, S.Tr.Ftr., MKM.

Dr. Nunuk Sri Purwanti, S.Kp., M.Kes.

dr. Jacoba Nugrahaningtyas Wahjuning Utami, M. Kes.

Ns. Destria Efliani, S.Kep., MM.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

PENTINGNYA KEBUGARAN FISIK PADA LANSIA

Penulis: Fatimah, S.Kp., M.Kep., Ns., Sp.Kep.Kom.
Gina Fazrina, S.Tr.Ftr., MKM.
Dr. Nunuk Sri Purwanti, S.Kp., M.Kes.
dr. Jacoba Nugrahaningtyas Wahjuning Utami, M. Kes.
Ns. Destria Efliani, S.Kep., MM.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-10-9369-1

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Seiring bertambahnya usia, kesehatan dan kebugaran fisik menjadi isu utama yang harus diperhatikan dengan serius. Populasi lansia yang terus meningkat menjadikan perhatian terhadap kebugaran fisik semakin krusial. Buku Referensi "Pentingnya Kebugaran Fisik pada Lansia" ini hadir sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kualitas hidup lansia melalui aktivitas fisik yang aman, efektif, dan menyenangkan.

Kami menyusun buku ini dengan harapan dapat menjadi panduan lengkap bagi lansia, keluarga, komunitas, serta tenaga kesehatan dalam merencanakan dan menerapkan aktivitas fisik yang sesuai kebutuhan lansia. Materi dalam buku ini disusun berdasarkan pendekatan ilmiah dan praktis, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta keterbatasan fisik yang umumnya dialami oleh lansia.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini. Semoga buku ini mampu memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi lansia dalam menjalani gaya hidup aktif dan sehat, sehingga mampu memperpanjang usia produktif serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I AKTIVITAS FISIK YANG AMAN DAN EFEKTIF UNTUK LANSIA.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Definisi Aktivitas Fisik, Exercise, dan Olahraga	2
C. Distribusi Intensitas dan Lama Waktu Aktivitas Fisik untuk Lansia.....	7
D. Program Latihan untuk Lansia	9
E. Olahraga untuk Lansia	11
F. Jenis Aktivitas Fisik yang dapat Dilakukan oleh Lansia dengan Penyakit Kronik dan Disabilitas	14
G. Kehati-hatian dalam Melakukan Aktivitas Fisik bagi Lansia	15
H. Kunci Sukses Lansia Beraktivitas Fisik	17
I. Penutup	19
Referensi.....	20
BAB II PENGARUH OLAHRAGA TERHADAP KESEIMBANGAN DAN MOBILITAS LANSIA	24
A. Pendahuluan.....	24
B. Olahraga Untuk Lansia.....	24
C. Pengaruh Olahraga Terhadap Keseimbangan Dan Mobilisasi Lansia	31
D. Asuhan Keperawatan Individu Lansia dengan Masalah Keseimbangan Dan Mobilisasi.....	34
E. Penutup	40
Referensi.....	42
BAB III KOLABORASI KOMUNITAS UNTUK MENCIPTAKAN PROGRAM KEBUGARAN LANSIA.....	46
A. Pendahuluan.....	46
B. Peran Komunitas dalam Kebugaran Lansia.....	47
C. Strategi Kolaborasi dalam Program Kebugaran Lansia.....	50
D. Model Program Kebugaran Lansia Berbasis Komunitas	53
E. Implementasi dan Tantangan Kolaborasi Komunitas dalam Program Kebugaran Lansia	59
F. Penutup	62
Referensi.....	64
BAB IV DUKUNGAN KELUARGA DALAM MENDUKUNG AKTIVITAS FISIK LANSIA.....	67
A. Pendahuluan.....	67
B. Keluarga Lansia dan Permasalahan Kesehatan pada Lansia	68
C. Dukungan Keluarga Terhadap Kesehatan Lansia	71
D. Aktifitas Fisik dan Pentingnya Aktivitas Fisik pada Lansia.....	73
E. Keamanan dan Kenyamanan Dalam Berkativitas Fisik Pada Lansia.....	77
F. Penutup	78
Referensi.....	79

BAB V PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM MEMBERIKAN PANDUAN OLAHRAGA

LANSIA.....	83
A. Pendahuluan.....	83
B. Tenaga Kesehatan	84
C. Olahraga Lansia	85
D. Peran Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan Panduan Olahraga Lansia	90
E. Penutup	91
Referensi.....	92
Profil Penulis	95

BAB I

AKTIVITAS FISIK YANG AMAN DAN EFEKTIF UNTUK LANSIA

A. Pendahuluan

Lansia atau lanjut usia merupakan istilah yang dipakai untuk seseorang yang sudah berusia 60 tahun atau lebih. Di Indonesia, populasi lanjut usia dikelompokkan ulang berdasarkan usia. Kelompok usia 49 – 59 tahun masuk pada Pra Lansia, 60 – 69 tahun merupakan kelompok Lansia Muda, 70 – 79 tahun merupakan kelompok Lansia Madya, dan usia lebih dari atau sama dengan 80 tahun merupakan kelompok Lansia Tua (Badan Pusat Statistik, 2023). Seiring dengan bertambahnya angka harapan hidup manusia, proporsi pertambahan jumlah penduduk lansia juga meningkat. Secara global, jumlah populasi orang berusia 60 tahun ke atas diperkirakan akan mencapai 2,1 miliar pada tahun 2050, meningkat dari 1,4 miliar pada tahun 2020 (Rudnicka et al., 2020). Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ditemukan bahwa proporsi penduduk lansia di Indonesia terus meningkat hingga mencapai sekitar 10,8% dari total populasi pada tahun 2022 dengan proporsi populasi lansia paling tinggi adalah Lansia Muda dengan presentase sebesar 63,59% (Badan Pusat Statistik, 2023)

Peningkatan proporsi populasi lansia menjadikan Indonesia masuk ke dalam periode *population ageing* atau penuaan penduduk, yaitu ketika proporsi jumlah penduduk usia lanjut semakin meningkat disertai dengan penurunan jumlah penduduk usia muda dalam suatu struktur populasi. Fenomena *population ageing* ini menjadikan upaya peningkatan kualitas kehidupan bagi lansia sebagai prioritas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengembangkan definisi *Healthy Ageing* 2020 – 2030 sebagai upaya peningkatan kualitas kesehatan lansia, yaitu berupa berbagai strategi untuk mengoptimalkan dan menjaga kemampuan fungsional lansia demi memaksimalkan kesejahteraan para lansia (Rudnicka et al., 2020).

Program *Healthy Ageing* 2020 – 2030 yang berprinsip pada *equity* dan *diversity* dapat diterapkan dalam pemberian edukasi maupun intervensi terkait aktivitas fisik pada lansia; sebagai salah satu upaya mengoptimalkan kebugaran fisik dan menjaga kemampuan fungsional. Penyedia layanan kesehatan dituntut untuk mampu memberikan edukasi terkait aktivitas fisik pada lansia dengan kualitas hasil yang sama, namun tetap mempertimbangkan kondisi keberagaman seperti: rentang usia lansia, keterbatasan fisik yang dimiliki, kondisi sosio-ekonomi, sampai dengan mempertimbangkan budaya yang dimiliki oleh lansia. Keberagaman kondisi ini memaksa penyedia layanan kesehatan untuk memiliki kapabilitas dalam membuat rancang bangun pemberian aktivitas fisik yang khusus.

Sayangnya, tidak semua tenaga kesehatan paham mengenai arti dan kekhususan tiap jenis aktivitas fisik. Salah kaprah aktivitas fisik yang digeneralisir sebagai olahraga, sering membuat pemberian edukasi dan intervensi aktivitas fisik menjadi kurang tepat sasaran, bahkan bisa jadi menimbulkan risiko terutama pada lansia. Maka dari itu, pembahasan terkait berbagai aktivitas fisik yang aman dan efektif untuk diberikan kepada lansia menjadi urgensi tersendiri untuk dikaji dan dipahami secara terperinci.

B. Definisi Aktivitas Fisik, Exercise, dan Olahraga

Istilah aktivitas fisik, *exercise* dan olahraga biasa disebut sebagai cara untuk meningkatkan kebugaran fisik. Ketiganya sering digeneralisir sebagai suatu istilah yang sama, padahal masing – masing memiliki konsep dan tujuan yang berbeda. Aktivitas fisik merujuk pada seluruh gerakan tubuh yang dihasilkan dari gerak otot rangka secara sadar dan membakar kalori (WHO, 2020). Berdasarkan definisi ini, maka bentuk aktivitas fisik dapat berupa aktivitas sehari – hari, aktivitas rekreasi, latihan secara spesifik, ataupun olahraga.

1. Aktivitas Sehari-hari

Aktivitas sehari-hari merupakan kegiatan yang dapat dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar seperti perawatan diri, makan, berpindah posisi, dan berpindah tempat (Edemenkong et al., 2023). Aktivitas sehari-hari juga membahas bagaimana seseorang mampu melakukan kegiatan yang lebih kompleks seperti membersihkan lingkungan, menyiapkan makanan, dan mengendarai kendaraan.

2. Aktivitas Rekreasi

Aktivitas rekreasi adalah aktivitas yang dikerjakan sebagai hiburan untuk bersantai menghilangkan penat (Obi, 2024). Aktivitas rekreasi ini biasa dilakukan saat waktu luang guna menyegarkan tubuh dan pikiran. Contoh dari aktivitas rekreasi diantaranya adalah berbagai hobi seperti melukis, mendaki gunung, bermain catur, bermain *video games*, termasuk olahraga rekreasional yang dilakukan murni untuk kesenangan seperti berenang, bersepeda, berjalan kaki, dan sebagainya.

3. Program Latihan

Latihan atau *exercise* memiliki pengertian yang lebih khusus. Secara teori, latihan didefinisikan sebagai aktivitas fisik terencana yang dilakukan secara sadar, terstruktur, dan berulang (Caspersen et al., 1985). Latihan didasari oleh tujuan yang jelas dan memiliki dosis dalam pengerjaannya. Latihan juga merupakan salah satu modalitas intervensi yang biasa dilakukan untuk menangani keluhan fungsi dan gerak tubuh (Kisner et al., 2018).

Beberapa latihan yang dibuat secara terencana, terstruktur, memiliki tujuan spesifik, dan berprogres biasa disebut sebagai *training*. Komponen *training* akan selalu berbeda, tergantung pada kondisi dan kebutuhan individu. Sebagai contoh *aerobic training* pada lansia dengan kondisi osteoarthritis lutut akan berbeda dengan *aerobic training* lansia yang bertujuan untuk mengikuti kompetisi olahraga.

4. Olahraga

Olahraga adalah aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, dilakukan secara sadar, dan memiliki seperangkat aturan yang harus dipatuhi. Contoh kegiatan olahraga diantaranya: tenis, badminton, lari marathon, sepak bola, dan kegiatan aktivitas fisik lain yang terstruktur serta melibatkan seperangkat aturan. Olahraga dapat dibagi menjadi olahraga kompetitif dan rekreasional. Olahraga kompetitif lebih memiliki tujuan untuk mencari pemenang dalam suatu pertandingan, sementara olahraga rekreasional dilakukan sebagai sarana rekreasi untuk menyegarkan tubuh dan pikiran, kegiatan ini tetap memiliki aturan berolahraga, namun memiliki tujuan yang tidak terpaku pada pencarian pemenang. Olahraga rekreasional dapat dikerjakan secara individu ataupun berkelompok dengan komunitas.

A. Intensitas Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik dapat dikelompokkan berdasarkan intensitas. Dalam aktivitas fisik, intensitas diartikan sebagai besar usaha dari kemampuan seseorang untuk bergerak dan berkegiatan. Parameter yang digunakan sebagai pengukuran intensitas aktivitas fisik memiliki banyak macamnya. Beberapa diantaranya membutuhkan penghitungan yang rumit dan menggunakan alat laboratorium. Namun ada juga yang cukup sederhana dan dapat diaplikasikan dengan mudah, diantaranya:

1. Tes Bicara saat Beraktivitas Fisik

Tes Bicara terbukti cukup sensitif untuk menilai perubahan kapasitas saat beraktivitas fisik (Saini et al., 2018). Saat seseorang melakukan aktivitas berat, maka dia membutuhkan asupan oksigen lebih besar dari biasanya melalui proses pertukaran udara dalam paru-paru yang semakin lebih sering. Sementara itu, kegiatan berbicara dapat menahan udara keluar dari paru-paru. Sehingga tidak mungkin jika seseorang dapat berbicara panjang ketika sedang melakukan aktivitas fisik berat.

Cara melakukan tes ini dapat dibilang cukup sederhana dan tidak membutuhkan banyak perlengkapan tambahan. Seseorang yang sedang melakukan aktivitas fisik hanya diminta untuk berbicara, dapat berupa membacakan teks, bercerita, bernyanyi, ataupun menjawab pertanyaan terbuka. Pemeriksa dapat melihat respon cara dia bernapas dan bercerita. Intensitas aktivitas fisik pada tes ini dikelompokkan berdasarkan syarat berikut;

a. Intensitas Ringan

Jika seseorang yang melakukan aktivitas fisik masih dapat berbicara dan bercerita dengan lancar, dapat bernyanyi, tanpa terengah-engah. Contoh aktivitas dengan intensitas ringan diantaranya: berjalan pelan, berpindah posisi dari tidur ke duduk

b. Intensitas Sedang

Jika seseorang yang melakukan aktivitas fisik masih dapat berbicara dan bercerita, namun tidak dapat bernyanyi, mulai terlihat secara sengaja mengatur napas. Contoh aktivitas dengan intensitas sedang diantaranya: bersepeda dengan kecepatan sedang, jalan cepat.

c. Intensitas Tinggi

Jika seseorang yang melakukan aktivitas fisik sudah kesulitan untuk berbicara dan bercerita beberapa kata sekaligus tanpa tidak menarik napas, terlihat terengah-engah. Contoh aktivitas dengan intensitas tinggi diantaranya: berlari, bersepeda dengan jalur menanjak.

Tes Bicara sangat cocok jika digunakan untuk melakukan aktivitas fisik intensitas sedang ke tinggi karena perubahan parameter yang terjadi dapat terlihat secara instan. Namun, tes ini tidak dapat dilakukan pada beberapa aktivitas fisik yang membutuhkan fokus, seperti contoh berenang. Tes ini juga tidak memiliki pengukuran persisi secara kuantitatif.

2. Denyut Nadi Maksimal

Pemeriksaan denyut nadi maksimal dapat menjadi pilihan saat tes bicara tidak dapat digunakan. Pemeriksaan ini memiliki keuntungan karena dapat menggambarkan parameter secara kuantitatif dan mampu membuat batasan seberapa maksimal usaha yang dapat dilakukan pada tiap-tiap jenis intensitas aktivitas fisik bergantung pada usia.

Parameter intensitas aktivitas fisik menggunakan pemeriksaan ini dapat dihitung melalui rumus **(denyut nadi saat latihan/denyut nadi maksimal) x 100%** dengan ketentuan penilaian:

- a. Intensitas Ringan jika hasil kurang dari 50%
- b. Intensitas Sedang jika hasil 50-70%
- c. Intensitas Tinggi jika hasil 70%

Penghitungan denyut nadi maksimal paling populer adalah dengan menggunakan rumus: $(220 - \text{usia})$. Namun, penghitungan tersebut diketahui hanya efektif untuk mengukur denyut nadi maksimal kelompok usia dewasa 30 sampai 40 tahun dan kurang sensitif jika diaplikasikan pada kelompok usia yang lebih muda ataupun lebih tua (Lach et al., 2022).

Penghitungan denyut nadi maksimal dapat diganti dengan menggunakan Rumus Tanaka, menggunakan rumus $(208 - 0.7 \times \text{usia})$. Rumus ini diketahui cenderung memiliki akurasi yang lebih sensitif untuk menggambarkan denyut nadi maksimal anak, remaja, dewasa, dan lansia sehat (Cicone et al., 2019; Tanaka et al., 2001).

3. Skala Borg RPE (*Rating Perceived Exertion*)

Skala Borg *Rating Perceived Exertion* atau penilaian persepsi penggunaan tenaga merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat usaha selama melakukan aktivitas (Borg et al., 1985). Secara teori, Skala Borg RPE dinilai dari skala 6 (amat sangat mudah bahkan tidak memerlukan usaha sama sekali) sampai dengan 20 (amat sangat berat, tidak tertahankan).

Saat sedang beraktivitas, seseorang diminta untuk merasakan sensasi berupa seberapa keras usaha yang dilakukan, seberapa sulit bernapas saat melakukan aktivitas, adakah rasa hangat atau pegal atau nyeri pada area otot yang bekerja, kemudian merangkumnya sebagai sebuah persepsi untuk menjawab "seberapa besar usaha yang diperlukan untuk mengerjakan aktivitas ini?"

4. Aplikasi Pelacak Status Kebugaran

Penggunaan alat pelacak status kebugaran yang terhubung pada aplikasi di ponsel pintar dapat sangat membantu untuk mengawasi informasi terkait status kebugaran diri. Seseorang dapat mencatat semua aktivitas yang dilakukan, seberapa besar intensitas yang dilakukan saat beraktivitas, sampai dengan mencatat status kebugaran yang dapat dilihat laju progresivitasnya secara harian, mingguan, sampai dengan bulanan. Namun penggunaan alat dan aplikasi pelacak status kebugaran tidak akan berpengaruh banyak pada perbaikan aktivitas fisik, tanpa kesadaran dan pengetahuan dari pengguna. Maka dari itu, penggunaan alat dan aplikasi pelacak status kebugaran akan lebih baik jika didukung oleh program yang diberikan dokter, Fisioterapis, dan pelatih fisik.

C. Distribusi Intensitas dan Lama Waktu Aktivitas Fisik untuk Lansia

Untuk mendapatkan hasil maksimal, WHO menyarankan agar lansia dapat melakukan aktivitas fisik intensitas sedang-ke-tinggi selama minimal 150 sampai dengan 300 menit dalam satu minggu, atau lansia dapat melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi selama 75 sampai dengan 150 menit dalam satu minggu. Lansia juga sangat direkomendasikan untuk menambah kegiatan aktivitas fisiknya dengan latihan penguatan otot minimal 2 hari per minggu dan latihan keseimbangan untuk mencegah risiko jatuh (WHO, 2020).

Secara umum diketahui bahwa aktivitas fisik dengan intensitas sedang-ke-tinggi secara terus menerus dapat mengurangi risiko kematian akibat dari penyakit kardiovaskular lebih baik daripada jika dilakukan secara tersebar sepanjang hari (Schwendinger et al., 2024). Jika temuan tersebut diaplikasikan pada lansia, dapat dipaparkan bahwa misalnya; lansia berjalan cepat tanpa henti selama 10 menit dengan intensitas sedang-ke-tinggi akan lebih bermanfaat, daripada berjalan cepat 10 kali selama 1 menit dengan intensitas yang sama.

Namun, manfaat yang lebih baik akan lebih dirasakan jika lansia tetap dapat mendistribusikan kegiatan tersebut secara merata dalam satu minggu dengan dibarengi dengan tetap bergerak aktif sepanjang hari. Kelompok usia dewasa dan lansia yang melakukan kegiatan secara aktif sepanjang hari dengan berbagai tingkatan intensitas akan lebih baik daripada melakukan aktivitas fisik intensitas tinggi sekaligus sepanjang hari (Tarp et al., 2024).

Daripada hanya berpatokkan pada satu jenis kegiatan latihan dan olahraga dengan intensitas tinggi dalam sehari, alangkah lebih baik jika lansia juga dapat bergerak aktif sepanjang hari. Aktivitas fisik yang dilakukan dapat berupa kombinasi intensitas rendah – sedang – tinggi dengan pengaturan waktu yang cukup, seperti contoh: berkebun pada pagi hari selama 1 jam, kemudian berenang selama 30 menit, dilanjutkan dengan berjalan-jalan santai bersama cucu di sore hari selama 45 menit. Lalu keesokan harinya, jadwal untuk berenang dapat diganti dengan senam lansia, bersepeda, atau bermain tenis bersama dengan komunitas olahraga. Lansia dapat memilih berbagai aktivitas fisik dengan intensitas sedang untuk dilakukan tiap 30 menit dalam sehari.

Distribusi lama waktu dan jenis aktivitas fisik tetap harus disesuaikan dengan kondisi fisik lansia. Lansia dengan keluhan gerak dan fungsi tubuh ataupun dengan penyakit kronis dan disabilitas harus tetap melakukan aktivitas. Namun, harus diarahkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan praktisi kesehatan, seperti dokter dan Fisioterapis agar lansia diberikan intervensi dan latihan yang dirancang khusus sehingga dapat mengurangi keluhan dalam beraktivitas.

D. Program Latihan untuk Lansia

Aktivitas fisik umum diketahui dapat meningkatkan kapasitas atau kemampuan tubuh secara keseluruhan, sedangkan program latihan memiliki fungsi lebih khusus. Latihan dapat dibuat dengan tujuan yang lebih spesifik seperti meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas gerak, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan kemampuan koordinasi dan keseimbangan, dan sebagainya. Karena manfaatnya yang khusus dan spesifik ini, maka program latihan sangat cocok untuk diberikan pada lansia dengan berbagai macam kondisi mulai dari yang mengalami penyakit kronik, disabilitas, sampai dengan atlet lansia yang akan mempersiapkan pertandingan. Maka dari itu, program latihan sudah sepantasnya dirancang eksklusif untuk kebutuhan perorangan dengan didampingi tenaga ahli yang mendalami gerak dan fungsi tubuh seperti Fisioterapis dan *physical trainer* atau pelatih fisik.

Program latihan fisik yang baik harus diawali dengan pemeriksaan kemampuan gerak dan fungsi tubuh secara spesifik, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan dari orang yang akan melakukan program latihan fisik. Setelahnya, program akan dirancang untuk dapat berprogres dengan peningkatan dosis latihan, lalu diikuti dengan evaluasi dari hasil program berupa pemeriksaan kembali kemampuan gerak dan fungsi yang telah ditargetkan di awal.

Program latihan yang disarankan WHO (2020) pada lansia adalah latihan peningkatan kekuatan otot minimal dua kali dalam seminggu serta program multikomponen yang di dalamnya meliputi latihan keseimbangan, kekuatan, daya tahan, pola jalan, dan latihan fungsional setidaknya tiga kali dalam seminggu. Dalam praktiknya, pemilihan jenis dan dosis latihan pada lansia harus didasari oleh kemampuan fisik awal, target, dan kebutuhan. Berikut ini merupakan beberapa jenis rekomendasi latihan multikomponen yang dapat diberikan pada lansia berdasarkan tujuan program;

1. Latihan untuk Menjaga Kapasitas Fungsional Lansia

- a. Latihan penguatan, seperti: penguatan satu atau lebih bagian tubuh dengan menggunakan *dumbbell*, *knee curls*, latihan *squat*
- b. Latihan aerobik, seperti: menaiki tangga, berenang
- c. Latihan keseimbangan, seperti: *tandem walking*, yoga
2. Latihan untuk Mencegah Risiko Jatuh
 - a. Latihan penguatan dan keseimbangan, seperti: *heel raises*, *toe raises*, berjalan menyamping
 - b. Latihan pola berjalan dengan pelampung di dalam kolam
3. Latihan untuk Mencegah Penurunan Fungsi Kognitif
 - a. Latihan penguatan
 - b. Latihan aerobik
 - c. *Brain gym*
 - d. Berjalan kaki sambil melafalkan alfabet secara berurutan dan terbalik

Perlu diingat kembali bahwa tidak semua lansia memiliki kondisi fisik yang baik dan tidak semua jenis latihan berlaku rata bagi seluruh lansia. Ada beberapa latihan yang jika sembarang dilakukan malah akan memperparah keluhan pada lansia. Sebagai contoh: jika lansia dengan osteoarthritis lutut diberikan latihan penguatan berupa *squat* tanpa memperbaiki postur dan posisi, hal ini akan memperparah kondisi degenerasi pada sendi lututnya. Inilah yang melatarbelakangi pernyataan mengapa pemberian program latihan harus didasari oleh pemeriksaan terlebih dahulu untuk kemudian dirancang secara khusus dan eksklusif dengan didampingi oleh Fisioterapis.

Selain jenis latihan di atas, lansia juga dapat diberikan program latihan fungsional. Pemberian latihan fungsional biasanya dilakukan setelah program latihan dasar sudah selesai dengan hasil evaluasi yang baik. Misalnya, jika latihan dasar hanya meningkatkan fleksibilitas gerakan menekuk dan meluruskan kaki, maka latihan fungsional lebih menekankan pada fungsi gerakan kaki seperti berjalan. Maka latihan fungsional untuk berjalan akan berupa: latihan keseimbangan

saat diam dan bergerak, serta latihan berjalan pada jalur yang memiliki beberapa rintangan.

E. Olahraga untuk Lansia

Ciri khas dari kegiatan olahraga adalah terstruktur, terencana, dan memiliki seperangkat aturan yang harus dipenuhi. Olahraga dapat dibedakan menjadi olahraga kompetitif dan rekreasional. Olahraga kompetitif biasanya cenderung di jauhi oleh lansia karena membutuhkan latihan secara profesional dan dianggap lebih berisiko daripada rekreasional, padahal keduanya memiliki risiko yang sama. Data dari 2002 – 2021 di Amerika Serikat menunjukkan bahwa dari 100.000 kegiatan olahraga kompetitif maupun rekreasional, terdapat 29 kejadian serangan jantung mendadak yang dialami lansia 65 tahun ke atas (Holmstrom et al., 2023).

Kegiatan olahraga baik secara kompetitif maupun rekreasional memang memiliki risiko terutama untuk lansia, namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan beberapa hal seperti: meningkatkan kapasitas kemampuan fisik secara bertahap dengan latihan dan *training* khusus, serta melakukan pemeriksaan kesehatan umum secara berkala untuk mengetahui adanya penyakit yang berisiko.

1. Olahraga Kompetitif

Olahraga ini biasa dilakukan oleh para profesional, termasuk para atlet lansia. Untuk mengikuti olahraga kompetitif, biasanya para atlet lansia harus meningkatkan kapasitas fisik yang dimilikinya melalui *training* yang dibuat dengan dosis sesuai dengan tujuan kebutuhan pertandingan. Karena seperti layaknya atlet secara umum, atlet lansia wajib memiliki kemampuan dan standar capaian minimum untuk dapat berpartisipasi dalam sebuah pertandingan. Sebagai contoh dalam kegiatan *National Senior Games* yang diadakan Amerika Serikat tahun 2025, atlet lansia laki – laki berusia 65 sampai 69 tahun yang akan mengikuti Lomba Gerak Jalan

1.500 meter harus mampu menempuh jarak tersebut dalam waktu 9 menit 34 detik (National Senior Games, 2024).

Atlet lansia juga akan diminta untuk mengevaluasi risiko gangguan kesehatan yang akan mengganggu penampilannya saat bertanding. Hal yang diperiksa dapat meliputi: indeks masa tubuh, total kolesterol, riwayat penyakit jantung, riwayat diabetes, sampai dengan riwayat keluarga dengan penyakit kardiovaskular (Chugh & Weiss, 2015).

Organisasi yang menyelenggarakan pertandingan olahraga kompetisi pada lansia harus melakukan perubahan peraturan dengan mempertimbangan kondisi fisik dan kemampuan lansia (Ericson & Geidne, 2023; National Senior Games, 2024), diantaranya:

- a. Memperpendek jarak lemparan bebas dalam pertandingan bola basket. Seharusnya jarak lemparan bebas adalah 4,6 meter, diubah menjadi menjadi 3,7 meter dalam pertandingan lansia.
- b. Mengubah lama pertandingan sepak bola. Berdasarkan FIFA (Federasi Sepak Bola Internasional) lama pertandingan sepak bola adalah 2 kali 45 menit. Namun untuk lansia, lama pertandingan diubah menjadi 2 x 30 menit.
- c. Mengubah panjang lapangan sepakbola menjadi maksimal 73,2 x 45,7 meter untuk pertandingan atlet lansia. Padahal seharusnya berukuran 110 x 75 meter.
- d. Meniadakan pertandingan sepak bola, lalu menggantinya dengan pertandingan akurasi tendangan bola sepak saja.

2. Olahraga Rekreasional

Banyak lansia yang cenderung lebih memilih olahraga rekreasional karena dilakukan dengan lebih santai, tidak menuntut profesionalitas dan tidak mengutamakan kompetisi. Contoh olahraga rekreasional diantaranya: bersepeda, badminton, berenang, *hiking* dan bisa juga berbagai aktivitas

permainan kelompok seperti permainan bola estafet, permainan tepuk tangan ceria, stik berantai, dan sebagainya (Obi, 2024; Sepdandius & Sugiyanto, 2015).

Olahraga rekreasional pada umumnya dapat dilakukan sendiri ataupun berkelompok dengan komunitas. Namun, olahraga rekreasional yang memiliki manfaat paling superior adalah olahraga rekreasional berbasis komunitas. Keuntungan olahraga rekreasional berbasis komunitas bagi lansia, diantaranya:

- a. Lansia diajak untuk mampu berinteraksi sosial, bekerjasama dan berpartisipasi dalam penyelesaian masalah, sehingga dapat meningkatkan efikasi diri atau keyakinan terhadap kemampuannya sendiri
- b. Lansia diberikan kesempatan untuk saling berbagi cerita bahwa proses penuaan itu merupakan hal yang wajar
- c. Lansia dapat saling belajar untuk melalui proses penuaan dengan bangga dan bahagia
- d. Lansia mampu saling memberikan dukungan emosi
- e. Lansia mampu memiliki keterikatan terhadap aktivitas fisik dengan lebih baik, karena dalam olahraga rekreasional berbasis komunitas terdapat berbagai kegiatan kompetisi yang membuat lansia tergerak untuk meningkatkan kemampuannya
- f. Lansia mampu memiliki peningkatan kapasitas fisik yang lebih baik, karena olahraga berbasis komunitas biasanya memiliki kegiatan peningkatan kapasitas fisik terstruktur untuk para anggota (Jenkin et al., 2016; Obi, 2024; Stenner et al., 2020).

F. Jenis Aktivitas Fisik yang dapat Dilakukan oleh Lansia dengan Penyakit Kronik dan Disabilitas

Menurut data Statistik Penduduk Lanjut Usia (2023), penyakit kronik yang biasa dialami lansia di Indonesia berupa penyakit jantung, diabetes, stroke, nyeri sendi atau arthritis, osteoporosis dan cedera. Penyakit kronik dapat menimbulkan gangguan pada fungsi tubuh sehingga mengganggu aktivitas fungsional dan berisiko menyebabkan disabilitas.

Agar dapat menjaga kebugaran fisik, WHO (2020) menyarankan agar lansia dengan penyakit kronis dan disabilitas untuk tetap beraktivitas fisik dengan minimal durasi dan intensitas yang sama dengan lansia tanpa keluhan. Hal ini tentu sangat berat untuk dilakukan, karena lansia dengan penyakit kronik dan disabilitas memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga dapat menyebabkan timbulnya masalah baru karena inaktivitas fisik. Maka, solusi yang paling efektif untuk mengatasinya adalah dengan pemberian program latihan secara spesifik.

Intervensi berupa program latihan terbukti mampu mengatasi berbagai keluhan terkait gerak dan fungsi tubuh pada populasi dengan penyakit kronik dan disabilitas (Anderson & Durstine, 2019; Pedersen & Saltin, 2015). Pembuatan program latihan pada lansia dengan penyakit kronis dan disabilitas harus berdasar pada pemeriksaan kondisi awal, pemberian intervensi program latihan multikomponen, dilanjutkan dengan program latihan fungsional dan mungkin untuk beberapa kasus akan membutuhkan latihan khusus dengan modifikasi alat bantu ataupun posisi beraktivitas. Modifikasi postur, posisi dan gerakan saat beraktivitas sehari-hari biasanya juga diberikan berbarengan dengan program latihan secara khusus yang menangani keluhan yang menyebabkan keterbatasan gerak dan fungsional tubuh pada lansia dengan penyakit kronik dan disabilitas.

G. Kehati-hatian dalam Melakukan Aktivitas Fisik bagi Lansia

Penurunan kondisi fisik lansia menjadi sebuah hal yang harus dipertimbangkan saat lansia berolahraga dan beraktivitas fisik. Beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan lansia saat melakukan aktivitas fisik diantaranya:

1. Sindroma *frailty*, yaitu penurunan energi cadangan tubuh disertai dengan peningkatan kerentanan terhadap stresor yang dapat menimbulkan masalah penyakit sehingga kapasitas fisik dan performa fungsional berkurang (Allison et al., 2021). Sindroma *frailty* sering dianggap sebagai kondisi normal penuaan. Gejalanya dapat berupa cara berjalan yang pelan, lemah dan mudah lelah, penurunan berat badan, penurunan fungsi aktivitas, penurunan keseimbangan, penurunan fungsi kognitif. Aktivitas fisik dengan intensitas sedang disertai dengan latihan penguatan dan keseimbangan perlu dilakukan untuk mengurangi keluhan yang disebabkan oleh sindroma *frailty*. Aktivitas fisik tetap dibutuhkan untuk lansia yang sudah mengalami disabilitas karena sindroma *frailty*. Pemberian aktivitas fisik dapat disesuaikan dengan berbagai modifikasi (seperti: senam dengan posisi duduk) disertai dengan paliatif serta intervensi lain untuk mengatasi gejala yang muncul.
2. Sarkopenia, yaitu penurunan massa dan fungsi otot rangka secara progresif (Yuan & Larsson, 2023). Sarkopenia dapat disebabkan oleh ketidak-aktifan secara fisik, penyakit kronis, diabetes, kurangnya asupan nutrisi, gangguan pola tidur, kebiasaan merokok dan proses penuaan. Pada lansia, kondisi sarkopenia disebabkan oleh berkurangnya motorneuron yang menyebabkan reinervasi saraf otot (proses terhubung kembalinya saraf otot yang terputus agar dapat kembali berfungsi) tidak terlaksana dengan baik (Lars Larsson et al., 2019). Aktivitas fisik secara berkala disertai dengan program latihan berupa penguatan otot dapat dilakukan untuk mencegah percepatan kejadian sarkopenia.

3. Osteoporosis, yaitu hilangnya kepadatan tulang karena jumlah dan aktivitas osteoblas menurun. Osteoblas adalah sel khusus yang berfungsi untuk membentuk sel tulang. Lansia yang mengalami osteoporosis akan lebih berisiko mengalami trauma dan patah tulang yang akan mengarah pada kondisi disabilitas. Aktivitas fisik yang melibatkan gravitasi dan pembebanan optimal (seperti: berjalan cepat dan berjalan pada jalur dengan bidang yang menanjak) sangat baik dilakukan untuk mencegah osteoporosis. Program latihan berupa penguatan otot dengan menggunakan beban secara optimal juga dapat sangat berpengaruh untuk mengurangi percepatan kejadian osteoporosis. Lansia dapat melakukan latihan penguatan dengan *dumbbell* seberat 1 Kg pada masing-masing lengan.
4. Penyakit degenerasi sendi, merupakan kondisi dimana kartilago pada bagian persendian secara progresif mengalami penurunan elastisitas menyebabkan kaku, keterbatasan gerak, dan nyeri kronik, sehingga penderita tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan nyaman. Aktivitas fisik dengan pembebanan berlebihan seperti *hiking* dan berjalan cepat mungkin dapat memperparah kondisi degenerasi sendi pada ekstermitas bawah. Pilihan aktivitas fisik lain seperti berenang dan bersepeda sangat dianjurkan untuk kondisi ini. Lansia dapat diarahkan untuk memeriksakan kondisi fisiknya lebih lanjut jika memiliki keluhan yang dicurigai mengarah pada kondisi degenerasi sendi.
5. Risiko jatuh. Lansia memiliki risiko jatuh yang tinggi. Hal ini disebabkan karena penurunan fungsi tubuh berupa penurunan fungsi sensori (penglihatan, pendengaran, proprioepsi, vestibular atau keseimbangan), penurunan fungsi otot, sampai dengan penurunan fungsi kognitif. Perbaikan pada masing-masing penurunan fungsi tubuh sangat

dibutuhkan melalui latihan multikomponen. Aktivitas fisik secara umum tetap dapat dilakukan oleh lansia dengan memodifikasi kondisi lingkungan, seperti: memasang bar sebagai alat untuk berpegangan saat menaiki tangga, menggunakan sepatu atau alas karet saat melakukan senam untuk menghindari jatuh terpeleset, serta memperbaiki penerangan rumah dan area sekitar agar lansia tidak kesulitan saat melakukan aktivitas sehari-hari.

H. Kunci Sukses Lansia Beraktivitas Fisik

Keberhasilan aktivitas fisik secara berkelanjutan pada lansia dipengaruhi oleh motivasi dari dalam diri dan dukungan lingkungan sekitar. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang melakukan sesuatu. Agar dapat melakukan aktivitas fisik secara sadar dan menjadikannya sebagai kebiasaan sehari-hari, lansia harus dapat memahami manfaat dari bergerak secara aktif dan memahami berbagai cara untuk mengatasi hambatan yang ditemukan saat beraktivitas fisik. Berikut beberapa tips yang dapat diaplikasikan agar lansia dapat melakukan aktivitas fisik tanpa keluhan:

1. Mulai aktivitas dengan dosis rendah, lalu tingkatkan secara perlahan
Misalnya hari ini lansia dapat mulai dengan berjalan santai selama 15 menit. Besoknya, lama waktu berjalan ditingkatkan menjadi 30 menit. Kemudian lusa, kecepatan berjalan dapat ditambah.
2. Pahami kekurangan diri saat beraktivitas
Misalnya ketika berjalan cepat, lansia merasakan terlalu terengah-engah. Maka solusi yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas aerobik dengan berenang. Contoh lain, lansia dengan disabilitas yang membutuhkan kursi roda dapat memodifikasi latihan berupa penguatan tangan dan senam dalam posisi duduk.
3. Jadikan semua aktivitas sebagai sarana berolahraga

Misalnya lansia dapat menggunakan tangga daripada *lift* dan eskalator saat sedang berbelanja di *mall*. Atau contoh lain: lansia dapat menyiram tanaman dengan ember dan gayung kecil daripada menggunakan selang.

4. Pelajari teknik dengan tepat

Tiap lansia memiliki kondisi tubuh, kebutuhan dan lingkungan yang berbeda. Maka, untuk mendapatkan hasil aktivitas fisik yang baik dibutuhkan pengetahuan yang memadai tentang cara latihan dan olahraga sesuai kebutuhan. Konsultasi dengan dokter, Fisioterapis, pelatih fisik, ataupun mengikuti komunitas olahraga dapat dilakukan sebagai upaya mempelajari teknik beraktivitas, latihan, dan berolahraga dengan benar tanpa keluhan.

5. Ikut komunitas olahraga yang disukai

Ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari mengikuti komunitas olahraga, yaitu: komunitas olahraga memiliki jadwal yang teratur sehingga peningkatan dosis olahraga dapat dilakukan secara teratur, komunitas olahraga dapat membantu lansia mengevaluasi serta mengatasi kekurangan diri saat berolahraga dan beraktivitas fisik, berbagai acara yang dibuat dalam komunitas olahraga juga dapat membantu lansia untuk tetap semangat beraktivitas fisik

6. Catat semua kegiatan, perkembangan dan tentukan tujuan

Agar tetap fit dan aktif tanpa keluhan, lansia dapat membuat catatan harian aktivitas fisik. Pencatatan dapat dilakukan secara manual ataupun secara digital dengan menggunakan alat pencatat kebugaran melalui jam tangan dan ponsel pintar. Pencatatan dapat berupa tujuan jangka panjang dan pendek, kekurangan dan keluhan yang dialami saat berolahraga, kegiatan

yang dilakukan selama sehari-hari, serta pemeriksaan rutin terkait level kebugaran.

I. Penutup

Sebagai seorang individu, lansia memiliki hak untuk tetap sehat tanpa penyakit berat, tanpa disabilitas, tanpa penurunan fungsi kognitif, tanpa penurunan fungsional, dan dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Maka, lansia sangat diwajibkan untuk tetap dapat bergerak dan beraktivitas fisik secara aktif. Beberapa informasi dan saran tentang aktivitas fisik yang aman dan efektif bagi lansia yang telah dipaparkan di atas semoga dapat membantu dalam pemilihan jenis aktivitas fisik bagi lansia.

Referensi

- Allison, R., Assadzandi, S., & Adelman, M. (2021). Frailty: Evaluation and Management. *Am Fam Physician*, 4(103), 219 – 226.
- Anderson, E., & Durstine, J. L. (2019). Physical activity, exercise, and chronic diseases: A brief review. *Sports Med Hlth Sci* 1(1), 3–10.
<https://doi.org/10.1016/j.smhs.2019.08.006>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023 Volume 20*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Borg, G., Ljunggren, G., & Ceci, R. (1985). The increase of perceived exertion, aches and pain in the legs, heart rate and blood lactate during exercise on a bicycle ergometer. *Eur J Appl Physiol Occup Physiol*, 54, 343–349.
<https://doi.org/10.1007/BF02337176>
- Caspersen, C. J., Powell, K. E., & Cristenson G M. (1985). Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. *Public Health Rep*, 2(100), 126–131.
- Chugh, S. S., & Weiss, J. B. (2015). Sudden Cardiac Death in the Older Athlete. *J Am Col Cardiol*, 65(5). <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2014.10.064>
- Cicone, Z. S., Holmes, C. J., Fedewa, M. V., MacDonald, H. V., & Esco, M. R. (2019). Age-Based Prediction of Maximal Heart Rate in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Res Q Exercise Sport*, 90(3), 417–428.
<https://doi.org/10.1080/02701367.2019.1615605>
- Edemenkong, P. F., Bomgaar, D. L., Sukumuran, S., & Schoo, C. (2023). *Activity of Daily Living*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470404/>.

- Ericson, H., & Geidne, S. (2023). The characteristics of organized sport and physical activity initiatives for older adults in Sweden. *Front Sports Act Living* 5. <https://doi.org/10.3389/fspor.2023.1168312>
- Holmstrom, L., Chugh, H. S., Uy-Evanado, A., Sargsyan, A., Sorenson, C., Salmasi, S., Norby, F. L., Hurst, S., Young, C., Salvucci, A., Jui, J., Reinier, K., & Chugh, S. S. (2023). Sudden Cardiac Arrest During Sports Activity in Older Adults. *JACC: Clin Electrophysiol*, 9(7), 893–903. <https://doi.org/10.1016/j.jacep.2022.10.033>
- Jenkin, C. R., Eime, R. M., Westerbeek, H., O’Sullivan, G., & van Uffelen, J. G. Z. (2016). Are they ‘worth their weight in gold’? Sport for older adults: benefits and barriers of their participation for sporting organisations. *International Journal of Sport Policy*, 8(4), 663–680. <https://doi.org/10.1080/19406940.2016.1220410>
- Kisner, Carolyn., Colby, L. Allen., & Borstad, John. (2018). *Therapeutic exercise: foundations and techniques 7th edition*. Philadelphia: F.A. Davis Company.
- Lach, J., Śliż, D., Wiecha, S., Price, S., Brzozowski, A., & Mamcarz, A. (2022). How to calculate a maximum heart rate correctly? *Folia Cardiol*, 17(5), 289–292. <https://doi.org/10.5603/fc.2022.0057>
- Lars Larsson, X., Degens, H., Li, M., Salviati, L., il Lee, Y., Thompson, W., Kirkland, J. L., Sandri, M., & Kogod, A. (2019). Sarcopenia: Aging-related Loss of Muscle Mass and Function. *Physiol Rev*, 99, 427–511. <https://doi.org/10.1152/physrev.00061>
- National Senior Games. (2024). *Official Sport Rules 2025 National Senior Games*. USA: National Senior Games Association
- Obi, L. (2024). The Role of Recreational Activities in Enhancing Quality of Life among the Elderly. *International Journal of Arts, Recreation and Sports*, 3 (3), 52 – 65.

- Pedersen, B. K., & Saltin, B. (2015). Exercise as medicine - Evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases. *Scand J Med Sci Sports*, 25, 1–72. <https://doi.org/10.1111/sms.12581>
- Rudnicka, E., Napierała, P., Podfigurna, A., Męczekalski, B., Smolarczyk, R., & Grymowicz, M. (2020). The World Health Organization (WHO) approach to healthy ageing. *Maturitas*, 139, 6–11. <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2020.05.018>
- Saini, M., Kulandaivelan, S., Devi, P., & Saini, V. (2018). The talk test—A costless tool for exercise prescription in Indian cardiac rehabilitation. *Indian Heart J*, 70, S466 – 470. <https://doi.org/10.1016/j.ihj.2018.09.009>
- Schwendinger, F., Infanger, D., Lichtenstein, E., Hinrichs, T., Knaier, R., Rowlands, A. V, & Schmidt-Trucksäss, A. (2024). Intensity or volume: the role of physical activity in longevity. *Eur J Prev Cardiol*, 32, 10 – 19. <https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwae295>
- Sepdandius, E., & Sugiyanto, F. X. (2015). Model Aktivitas Rekreatif Kompetitif untuk Meningkatkan Kesehatan Psikososial dan Memelihara Daya Ingat Lansia. *Medikora*, XVI. <https://doi.org/10.21831/medikora.v14i2.7934>
- Stenner, B. J., Buckley, J. D., & Mosewich, A. D. (2020). Reasons why older adults play sport: A systematic review. *J Sport Health Sci*, 9(6), 530–541. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2019.11.003>
- Tanaka, H., Monahan, K. D., & Seals, D. R. (2001). Age-Predicted Maximal Heart Rate Revisited. *J Am Col Cardiol*, 37 (1).
- Tarp, J., Dalene, K. E., Fagerland, M. W., Steene-Johannesen, J., Hansen, B. H., Anderssen, S. A., Hagströmer, M., Dohrn, I. M., Dempsey, P. C., Wijndaele, K., Brage, S., Nordström, A., Nordström, P., Diaz, K. M., Howard, V. J., Hooker, S. P., Morseth, B., Hopstock, L. A., Sagelv, E. H., ... Ekelund, U. (2024). Physical Activity Volume, Intensity, and Mortality: Harmonized Meta-Analysis of Prospective Cohort

Studies. *Am J Prev Med.* 67(6). 887 – 896.
<https://doi.org/10.1016/j.amepre.2024.07.022>

WHO. (2020). *WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behavior*. World Health Organization.

Yuan, S., & Larsson, S. C. (2023). Epidemiology of sarcopenia: Prevalence, risk factors, and consequences. *Metab Clin Exp*, 144(155533).
<https://doi.org/10.1016/j.metabol.2023.155533>

BAB II

PENGARUH OLAHRAGA TERHADAP KESEIMBANGAN DAN MOBILITAS LANSIA

A. Pendahuluan

Olahraga adalah salah satu kegiatan yang baik untuk lansia. Jenis latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kesesuaian yang efektif pada lansia adalah senam, misalnya erobik. (Hasanah, Widhowati, Nugroho, Nahdliyah, Ikbal, dan Baniyati, 2023). Jumlah lansia di Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia pada 2023, mencapai 12 persen atau sekitar 29 juta jiwa (Kemenkes RI, 2024). Peningkatan jumlah lansia ini dapat menyebabkan penurunan kesehatan, kesejahteraan dan kualitas hidup lansia apabila tidak menerapkan pola hidup sehat. GERMAS adalah pola hidup sehat yang dianjurkan oleh pemerintah Indonesia terdiri dari aktivitas fisik atau olahraga yang teratur, mengonsumsi sayur dan buah minimal 2 porsi sehari, tidak merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol, rutin melakukan pemeriksaan Kesehatan, selalu menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan jamban (Shalma, 2025).

B. Olahraga Untuk Lansia

Pola aktivitas dan olahraga berkaitan dengan perilaku olah raga, aktivitas, waktu senggang, dan rekreasi (Williams, 2016). Pada lansia, aktivitas fisik memberikan manfaat pada hasil kesehatan berikut: penurunan angka kematian karena semua penyebab, angka kematian akibat penyakit kardiovaskular, kejadian hipertensi, kejadian kanker spesifik lokasi kejadian, kejadian diabetes tipe-2, kesehatan mental (pengurangan gejala kecemasan dan depresi), kesehatan kognitif, dan tidur; ukuran adipositas juga dapat menurun. Aktivitas fisik pada lansia dapat membantu mencegah jatuh dan cedera akibat jatuh serta penurunan kesehatan

tulang dan kemampuan fungsional (WHO, 2020). Aktivitas fisik yang teratur dapat dimasukkan ke dalam aktivitas kehidupan dengan berbagai cara. Orang mendapat manfaat dari aktivitas fisik sepanjang hidup, termasuk seiring bertambahnya usia (CDC, 2023).

1. Olahraga Untuk Lansia (65 tahun ke atas)

Lanjut usia harus melakukan aktivitas fisik aerobik intensitas sedang setidaknya selama 150-300 menit; atau setidaknya 75–150 menit aktivitas fisik aerobik intensitas tinggi; atau kombinasi aktivitas intensitas sedang dan berat yang setara sepanjang minggu, untuk memberikan manfaat kesehatan yang besar (WHO, 2020). Lanjut usia 65 tahun ke atas, memerlukan aktivitas aerobik, penguatan otot, dan keseimbangan setiap minggunya, (CDC, 2023). Selain itu, lansia harus melakukan kegiatan penguatan otot dengan kekuatan sedang atau lebih besar di mana semua kelompok otot penting terlibat setidaknya 2 hari seminggu, karena kegiatan ini memberikan manfaat kesehatan tambahan.

Beberapa pernyataan praktik aktivitas fisik yang baik:

- a. Melakukan beberapa aktivitas fisik lebih baik daripada tidak melakukan apa pun.
- b. Jika lansia tidak memenuhi rekomendasi, dengan melakukan aktivitas fisik akan membawa manfaat bagi kesehatan.
- c. Lanjut usia sebaiknya memulai aktivitas fisik dalam jumlah kecil, dan secara bertahap frekuensi, intensitas, dan durasinya ditingkatkan seiring berjalannya waktu.
- d. Lanjut usia harus aktif secara fisik sesuai kemampuan fungsionalnya, dan menyesuaikan tingkat upaya aktivitas fisiknya sesuai dengan tingkat kebugarannya.

Rekomendasi WHO bagi aktivitas fisik lansia:

- a. Lansia harus banyak bergerak dan tidak menghabiskan waktunya hanya dengan berdiam diri. Lansia dapat mengurangi aktivitas duduk dengan berbagai aktivitas fisik meskipun intensitas ringan karena akan memberikan manfaat kesehatan.
- b. Untuk membantu mengurangi dampak buruk dari perilaku sedentari tingkat tinggi terhadap kesehatan, orang lanjut usia harus berusaha melakukan lebih banyak aktivitas fisik yang mempunyai intensitas sedang hingga berat yang telah direkomendasikan.

2. Olahraga Untuk Dewasa Dan Lansia Dengan Kondisi Kronis

Aktivitas fisik dapat memberikan manfaat kesehatan bagi orang dewasa dan orang tua yang hidup dengan penyakit kronis. WHO merekomendasikan bahwa semua orang dewasa dan lansia dengan penyakit kronis harus secara teratur menjalani aktivitas fisik. Orang dewasa dan lansia dengan penyakit kronis harus melakukan olahraga aerobik setidaknya selama 150-300 menit atau aktivitas fisik aerobik pada intensitas tinggi setidaknya selama 75-150 menit. Atau kombinasi yang setara dengan aktivitas intensif sedang dan parah pada hari kerja untuk mencapai manfaat kesehatan yang hebat.

Tanpa kontraindikasi, orang dewasa dan orang dewasa yang lebih tua dengan penyakit kronis dapat meningkatkan aktivitas fisik aerobik pada intensitas sedang selama lebih dari 300 menit. Atau intensitas aerobik aktivitas fisik melebihi 150 menit. Atau kombinasi kegiatan intensitas sedang dan parah yang sesuai dengan mingguan untuk mencapai manfaat kesehatan tambahan. Pernyataan praktik terbaik berikut:

- a. Jika Anda tidak dapat memenuhi rekomendasi di atas, orang dewasa dengan penyakit kronis harus melakukan aktivitas fisik sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

- b. Orang dewasa dengan penyakit kronis harus mulai melakukan aktivitas fisik secara bertahap mulai dari intensitas rendah lalu ditingkatkan baik frekuensi, intensitas, maupun durasinya dari waktu ke waktu.
- c. Orang dewasa dengan penyakit kronis disarankan untuk mencari nasihat profesional Kesehatan tentang jenis dan jumlah kegiatan yang memenuhi fungsi seperti perawatan, kebutuhan perencanaan perawatan umum, keterampilan, dan keterbatasan/komplikasi.
- d. Izin medis umumnya tidak diperlukan untuk individu yang tidak memiliki kontraindikasi sebelum aktivitas fisik intensitas sedang dimulai.

Pada orang dewasa, termasuk penyintas kanker dan pengidap hipertensi, diabetes tipe-2, dan HIV, jumlah perilaku sedentari yang lebih tinggi dikaitkan dengan dampak kesehatan yang buruk berikut ini: kematian akibat semua penyebab, kematian akibat penyakit kardiovaskular, dan kematian akibat kanker, serta kejadian penyakit kardiovaskular, kanker, dan diabetes tipe-2.

3. Olahraga Untuk Dewasa Dan Lansia Dengan Disabilitas

Manfaat tambahan dari aktivitas fisik terhadap hasil kesehatan bagi mereka yang hidup dengan disabilitas mencakup hal-hal berikut: untuk orang dewasa dengan multiple sclerosis – peningkatan fungsi fisik, dan kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan secara fisik, mental, dan sosial; untuk individu dengan cedera tulang belakang – peningkatan fungsi berjalan, kekuatan otot, dan fungsi ekstremitas atas; dan peningkatan kualitas hidup terkait kesehatan; untuk individu dengan penyakit atau kelainan yang mengganggu fungsi kognitif – peningkatan fungsi fisik dan kognisi (pada individu dengan penyakit Parkinson dan mereka yang memiliki riwayat stroke); efek menguntungkan pada kognisi; dan dapat meningkatkan kualitas hidup (pada orang dewasa penderita skizofrenia); dan dapat meningkatkan fungsi fisik (pada orang dewasa penyandang disabilitas intelektual); dan meningkatkan kualitas hidup (pada orang dewasa dengan depresi klinis berat). Rekomendasi

WHO: Semua orang dewasa penyandang disabilitas harus melakukan aktivitas fisik secara teratur

Penyandang disabilitas dewasa seharusnya melakukan aktivitas fisik aerobik dengan intensitas sedang paling tidak 150–300 menit; atau setidaknya 75–150 menit aktivitas fisik aerobik intensitas tinggi; atau kombinasi setara aktivitas dengan intensitas sedang dan berat setiap minggu untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang besar.

Pernyataan praktik terbaik dari WHO:

- a. Lansia yang melakukan aktivitas fisik akan menjadi lebih baik daripada tidak melakukan aktivitas apa pun.
- b. Jika penyandang disabilitas dewasa tidak memenuhi rekomendasi ini, melakukan aktivitas fisik akan membawa manfaat bagi kesehatan.
- c. Penyandang disabilitas dewasa harus memulai dengan melakukan sedikit aktivitas fisik, dan secara bertahap meningkatkan frekuensi, intensitas, dan durasinya seiring berjalannya waktu
- d. Tidak ada risiko besar bagi orang dewasa penyandang disabilitas yang melakukan aktivitas fisik jika hal tersebut sesuai dengan tingkat aktivitas, status kesehatan, dan fungsi fisik individu tersebut saat ini; dan ketika manfaat kesehatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan risikonya.
- e. Penyandang disabilitas dewasa mungkin perlu berkonsultasi dengan profesional kesehatan atau spesialis aktivitas fisik dan disabilitas lainnya untuk membantu menentukan jenis dan jumlah aktivitas yang sesuai untuk mereka.

Pada orang dewasa, jumlah perilaku sedentary yang lebih tinggi dikaitkan dengan dampak kesehatan yang buruk berikut ini: angka kematian untuk semua penyebab, kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskular, kasus

kematian karena kanker, penyakit kardiovaskular, berbagai jenis kanker, dan diabetes tipe-2.

Rekomendasi WHO (2020):

- a. Orang dewasa penyandang disabilitas harus mulai mengurangi waktu yang digunakan tanpa melakukan aktivitas fisik. Waktu relaksasi dapat diganti dengan aktivitas fisik dengan intensitas yang paling ringan juga memiliki manfaat kesehatan.
- b. Orang dewasa penyandang disabilitas seharusnya juga melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga berat melebihi dari jumlah yang direkomendasikan untuk mempertahankan kesehatan.

Dibawah ini adalah macam-macam jenis olahraga yang dapat dilakukan para lansia menurut Kurniadi (2020) dan Adrian (2023):

- a. Jalan kaki cepat (*Brisk Walking*)

Jalan kaki merupakan olahraga paling mudah untuk dilakukan lansia. Jalan kaki dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa alat khusus. Jalan kaki apabila dilakukan secara teratur mempunyai pengaruh terhadap penurunan risiko penyakit jantung, dan meningkatkan kesehatan tulang, serta suasana hati.

- b. Yoga

Yoga merupakan olahraga yang dilakukan melalui kombinasi latihan pernapasan, meditasi, dan gerakan tubuh yang perlahan. Yoga dapat membantu lansia untuk meningkatkan fleksibilitas, koordinasi dan keseimbangan. Yoga dapat terbukti dapat mengurangi kecemasan dan tingkat stres serta meningkatkan kualitas tidur.

- c. Berenang

Aktivitas berenang dapat memberikan pengaruh positif pada lansia dengan cara mengurangi tekanan pada sendi dan juga mempengaruhi kekuatan

otot menjadi lebih kuat tanpa menyebabkan stres yang berlebihan. Olahraga ini juga dapat meningkatkan kekuatan otot dan sendi, melancarkan aliran darah, serta baik untuk kesehatan jantung, otak, dan paru-paru

d. Qi gong dan Tai Chi

Olahraga Tai Chi, dilakukan dengan gerakan yang lembut dan berfokus pada pernapasan. Olahraga ini dapat meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan kekuatan otot pada lansia, dan terbukti mengurangi risiko jatuh, memperbaiki kualitas tidur serta suasana hati lansia. Qi gong dan tai chi merupakan bentuk olah raga dari Asia yang populer, karena tidak menimbulkan tekanan pada tubuh sehingga latihan ini bermanfaat bagi tubuh dan pikiran.

e. Latihan beban

Salah satu penelitian menunjukkan bahwa latihan resisten pada lansia dapat meningkatkan kekuatan otot dan fungsional aktivitas sehari-hari.

f. Bersepeda

Bersepeda baik untuk meningkatkan kekuatan tulang dan sendi, serta menjaga kesehatan jantung. Namun, guna mencegah terjadinya cedera, gunakan selalu pelindung saat bersepeda, seperti helm. Tak hanya itu, aturlah kembali sadel serta pegangan sepeda sesuai dengan postur tubuh.

g. Berdansa

Melakukan gerakan dansa sambil diiringi musik atau lagu kesenangan tentu menjadi aktivitas yang sangat menyenangkan. Tak hanya itu, ternyata berdansa juga baik untuk menjaga kebugaran dan keseimbangan tubuh.

h. Pilates

Pilates merupakan salah satu bentuk latihan fisik yang umumnya banyak dilakukan oleh anak muda. Namun, saat ini, beberapa kelas pilates juga menyediakan program latihan khusus bagi para lansia.

Selama latihan, lansia harus memperhatikan beberapa hal untuk menjaga kesehatan dan keselamatan yaitu pertama hubungi dokter sebelum memulai program olahraga baru, kondisi seperti lansia yang memiliki penyakit tertentu atau sedang minum obat tertentu. Kedua pendinginan sebelum olahraga dan pendinginan setelah berolahraga harus diperhatikan untuk mengurangi risiko otot dan sendi. Juga, hindari kegiatan yang terlalu kaku atau terlalu kuat untuk melatih Kesehatan dan keterampilan fisik lansia. Selalu dengarkan tubuh dan berhenti olahraga kapan pun lansia merasa tidak nyaman atau memiliki tanda-tanda masalah kesehatan. Akhirnya, minum banyak air dan gunakan pakaian dan sepatu yang sesuai yang nyaman dan mendukung. Dengan mengamati hal-hal ini, lansia dapat dengan aman dan efektif melakukan program olahraga.

Tubuh kita berubah seiring bertambahnya usia, tetapi jika kita dapat terus bergerak dan berlatih secara teratur, orang yang lebih tua dapat menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. GO, yoga, berenang, tai chi dan latihan kekuatan adalah contoh olahraga yang dapat dilakukan untuk orang tua. Hubungi dokter atau profesional kebugaran Anda sebelum memulai program olahraga baru, terutama jika senior Anda memiliki masalah kesehatan sebelumnya.

C. Pengaruh Olahraga Terhadap Keseimbangan Dan Mobilisasi Lansia

Berikut ini adalah pengaruh olahraga terhadap keseimbangan lansia:

1. **Latihan Keseimbangan dan Ankle Strategy Exercise:** Penelitian oleh Permana et al. (2022) menunjukkan bahwa kombinasi latihan keseimbangan dan ankle strategy exercise dapat meningkatkan fungsi motorik dan keseimbangan pada lansia dengan risiko jatuh.
2. **Balance Exercise (Latihan Keseimbangan):** Ayatullah (2023) meneliti pengaruh latihan keseimbangan terhadap risiko jatuh pada lansia di BSLU Meci Angi Kota Bima, menemukan bahwa latihan tersebut dapat menurunkan frekuensi jatuh pada lansia.

3. **Senam Lansia:** Andria et al. (2021) meneliti pengaruh senam terhadap tingkat keseimbangan tubuh lansia di Balai Pelayanan dan Penyantunan Lansia Kota Bengkulu, menemukan bahwa senam dapat meningkatkan keseimbangan tubuh lansia.
4. **Aktivitas Fisik dan Keseimbangan:** Penelitian oleh Sari et al. (2020) menunjukkan bahwa aktivitas fisik seperti senam lansia, bersepeda, dan jalan kaki dapat melatih keseimbangan tubuh, mencegah penyakit, dan menjaga kesehatan tubuh lansia.
5. **Latihan Keseimbangan dalam Pencegahan Jatuh:** Suciana et al. (2018) menemukan bahwa senam kebugaran lansia mempunyai pengaruh terhadap rata-rata waktu risiko jatuh, sehingga dapat digunakan sebagai upaya pencegahan jatuh pada lansia.
6. **Pengaruh Latihan Aktivitas Fisik terhadap Keseimbangan Dinamis:** Khaerunisa (2021) meneliti pengaruh latihan aktivitas fisik terhadap keseimbangan dinamis pada lansia, menemukan bahwa latihan tersebut efektif dalam meningkatkan keseimbangan dinamis.
7. **Pengaruh Balance Exercise terhadap Tingkat Keseimbangan:** Azizah et al. (2025) meneliti pengaruh balance exercise terhadap tingkat keseimbangan pada lansia, menemukan bahwa latihan tersebut efektif dalam meningkatkan keseimbangan dan menurunkan risiko jatuh.
8. **Latihan Keseimbangan dalam Pencegahan Jatuh:** Penelitian oleh Syapitri (2016) menunjukkan bahwa latihan swiss ball dapat meningkatkan keseimbangan tubuh dan mengurangi risiko jatuh pada lansia.
9. **Aktivitas Fisik dan Keseimbangan Statis:** Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas fisik, maka semakin baik keseimbangan statis pada lansia, begitu juga sebaliknya.
10. **Latihan Keseimbangan dan Risiko Jatuh:** Penelitian menunjukkan bahwa latihan keseimbangan dapat membantu meningkatkan kekuatan otot pada

anggota bawah dan sistem vestibular, sehingga mengurangi risiko jatuh pada lansia.

Olahraga memiliki peran penting dalam meningkatkan mobilitas pada lansia, yang dapat meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup mereka. Berikut ini adalah pengaruh olahraga terhadap mobilisasi lansia:

1. **Latihan Fisik dan Kebugaran Lansia:** Penelitian menunjukkan bahwa senam lansia berpengaruh positif terhadap kebugaran jantung paru lansia, yang dapat meningkatkan kemampuan mobilisasi mereka. Pemberian senam lansia juga mampu memotivasi lansia penderita hipertensi untuk lebih aktif, sehingga meningkatkan mobilisasi mereka (Anuar & Norlinta, 2021)
2. **Latihan ROM Aktif dan Mobilisasi:** Penelitian oleh Setyorino & Setyaningrum (2019) dan Uli dkk (2019) menunjukkan bahwa latihan Range of Motion (ROM) aktif dapat meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas sendi, dan kemampuan mobilisasi pada lansia.
3. **Terapi Latihan dan Kualitas Hidup:** Studi literatur oleh Anuar R., Imani D.R., dan Norlinta S.N.O. (2021) membahas bagaimana intervensi fisioterapi berupa terapi latihan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup pada lansia, termasuk aspek mobilisasi.
4. **Latihan Keseimbangan dan Risiko Jatuh:** Penelitian oleh Ayatullah (2023) menemukan bahwa latihan keseimbangan dapat menurunkan frekuensi jatuh pada lansia, yang secara tidak langsung meningkatkan mobilisasi mereka.
5. **Senam Kebugaran Lansia dan Risiko Jatuh:** Penelitian oleh Suciana dkk. (2018) menunjukkan bahwa senam kebugaran lansia berpengaruh terhadap penurunan risiko jatuh, yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam mobilisasi.
6. **Latihan ROM Aktif dan Kekuatan Otot:** Penelitian oleh Sunarti & Silalahi (2018) menunjukkan bahwa latihan ROM aktif dapat meningkatkan kekuatan otot lansia, yang berkontribusi pada peningkatan kemampuan mobilisasi.

7. **Foam Rolling Exercise dan Neuro Mobilisasi:** Penelitian oleh Savitri, K.M.B. (2020) menunjukkan bahwa foam rolling exercise dan neuro mobilisasi berpengaruh terhadap fleksibilitas otot pada lansia, yang dapat meningkatkan mobilisasi mereka.
8. **Senam Lansia dan Tekanan Darah:** Penelitian oleh Yantina & Saputri (2019) menunjukkan bahwa senam lansia dapat menurunkan tekanan darah pada wanita lansia dengan hipertensi, yang dapat meningkatkan kemampuan mobilisasi mereka.

D. Asuhan Keperawatan Individu Lansia dengan Masalah Keseimbangan Dan Mobilisasi

Menurut Williams (2016) lanjut usia biasanya mengalami beberapa perubahan kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas fisik. Ini perubahan mungkin disebabkan oleh perubahan normal akibat penuaan atau dari beberapa perubahan patologis.

1. Pengkajian

Perawat mengumpulkan data fokus dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: Apakah individu lansia mempunyai rentang gerak yang penuh pada persendiannya? Apakah lansia menderita kontraktur atau kelainan bentuk? Apakah lansia merasakan nyeri atau nyeri tekan di persendian? Apakah ada gerakan tertentu yang memperberat nyeri sendi? Apa yang meredakan nyeri? Bagaimana tonus otot lengan dan kaki? Apakah kekuatan otot sama pada kedua sisi tubuh? Apakah ada nyeri tekan di otot? Apakah lansia merasa nyaman dan percaya diri menggunakan alat bantu ini? Apakah lansia memerlukan bantuan orang lain orang yang akan diambulasi? Jika lansia tidak dapat berjalan, apa yang dia lakukan tingkat aktivitas? Apakah lansia menggunakan kursi roda? Apakah lansia dapat mengoperasikan kursi rodanya secara mandiri? Apakah lansia menerima rentang gerak pasif latihan? Apakah lingkungan aman bagi individu?

Faktor risiko terkait gangguan mobilitas fisik pada lansia antara lain:

- a. Intoleransi aktivitas fisik karena alasan medis kondisi yang menurunkan daya tahan atau kekuatan
- b. Nyeri
- c. Kondisi neuromuskular atau muskuloskeletal
- d. Gangguan kognitif (penyakit Alzheimer atau demensia)
- e. Kecemasan atau depresi berat
- f. *Bedrest*
- g. Perangkat pembatas (pengekangan, gips, belat, dan *immobilizer*)

Faktor Risiko Terkait Intoleransi Aktivitas pada gaya hidup menetap pada lanjut usia:

- a. Menurunnya rasa berharga, harga diri, atau kebebasan
- b. Kelemahan umum, imobilitas, *bedrest*
- c. Masalah yang berhubungan dengan oksigenasi
- d. Gangguan kognitif (penyakit Alzheimer atau demensia)
- e. Kurang gizi

Alat pengkajian *Exercise and Screening for You* (EASY) adalah alat *screening* yang dapat digunakan untuk menentukan program olahraga yang aman untuk lanjut usia berdasarkan masalah fisik yang dialami. Lanjut usia yang lemah memerlukan pengkajian yang lebih komprehensif dan pemantauan ketat untuk memastikan manfaat tanpa kompromi keamanan. Tujuan latihan untuk orang lanjut usia yang lemah adalah berbeda dengan orang dewasa muda. Berolahraga di usia yang lebih muda membantu mencegah penyakit dan meningkatkan harapan hidup. Bagi lansia yang lemah, olahraga penting untuk meminimalkan efek penuaan, membalikkan efek jika tidak digunakan, dan memaksimalkan kesehatan psikologis.

Kontraindikasi dilakukannya olahraga pada lansia dengan perubahan hasil elektrokardiogram terkini atau infark miokard; angina tidak stabil; dan aritmia yang tidak terkontrol, blok jantung derajat tiga, dan gagal jantung akut. Diabetes yang tidak terkontrol, parah hipertensi, penyakit pernafasan, muskuloskeletal akut nyeri, dan radang sendi adalah kondisi lain yang memerlukan kehati-hatian penilaian sebelum program latihan dimulai. Latihan program mungkin perlu disesuaikan tergantung kondisinya individu (misalnya, program latihan renang daripada aktivitas resistensi, seperti mengangkat beban atau menggunakan pita elastis, jika orang tua menderita radang sendi).

2. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan yang dapat ditegakkan perawat adalah:

- a. Gangguan mobilitas Fisik
- b. Intoleransi Aktivitas

3. Tujuan Keperawatan

Tujuan keperawatan bagi individu lansia dengan gangguan fisik mobilitas adalah:

- a. meningkatkan partisipasi fisik kegiatan yang menjaga kekuatan dan mobilitas
- b. mempertahankan posisi dan fungsi anatomi normal secara keseluruhan sendi
- c. tetap bebas dari kontraktur sendi dan *foot drop*
- d. mempertahankan atau meningkatkan kekuatan dan mobilitas menggunakan alat bantu.

Tujuan keperawatan untuk lanjut usia dengan intoleransi aktivitas adalah untuk:

- a. menunjukkan peningkatan kemampuan untuk bertoleransi kegiatan

- b. mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap intoleransi aktivitas.

4. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mobilisasi fisik adalah:

- a. Identifikasi tingkat aktivitas yang ditentukan.

Aktivitas tingkatnya ditetapkan oleh penyedia layanan primer berdasarkan status kesehatan lansia secara keseluruhan. Pasien harus seaktif mungkin namun tidak melebihi tingkat aktivitas yang ditentukan.

- b. Kaji kekuatan dan mobilitas sendi secara teratur.

Kekuatan dan mobilitas sendi tidak selalu konsisten pada lansia. Perubahan mungkin disebabkan oleh sesuatu yang sederhana seperti perubahan cuaca, atau mungkin merupakan indikasi awal adanya perubahan status kesehatan orang lanjut usia. Nilailah dengan cermat mobilitas jika lansia mengalami kelemahan atau jatuh. Segera laporkan setiap perubahan akut pada penilaian seperti kelemahan sepihak atau sakit parah pada penyedia layanan primer.

- c. Melakukan aktivitas mobilitas fisik secara bersamaan dengan perawatan sehari-hari.

Melakukan latihan ROM pasif bersamaan dengan mandi. Gabungkan olahraga aktif sebagai bagian dari berpakaian, makanan, perawatan, toileting, dan ADL lainnya bahkan partisipasi yang minimal dalam ADL dapat meningkatkan fisik mobilitas. Latihan apa pun yang dilakukan oleh lansia saat mandi, menyisir rambut, dan mulut kebersihan yang menggunakan sendi dan otot bisa bermanfaat.

- d. Memberikan keselarasan tubuh dan sering mengubah posisi.

Lanjut usia yang terbaring di tempat tidur berada pada kondisi yang tinggi risiko hilangnya mobilitas sendi. Posisi yang lama bisa mengakibatkan

kelelahan otot, yang meningkatkan kemungkinan terjadi kontraktur. Kontraktur fleksi pada pinggul, lutut, dan kaki terjadi ketika fleksor otot mendominasi. Kontraktur ini dapat mengakibatkan kehilangan kemampuan untuk berdiri atau berjalan secara permanen. Untuk mencegahnya, selalu berikan keselarasan yang baik dan mengubah posisi. Gunakan alat pemosisian (bantal, gulungan trokanter, dan penyangga kaki/*foot board*) bila diperlukan untuk menjaga keselarasan yang tepat.

- e. Hindari pengekangan/*restraint* yang tidak perlu yang membatasi fisik mobilitas.

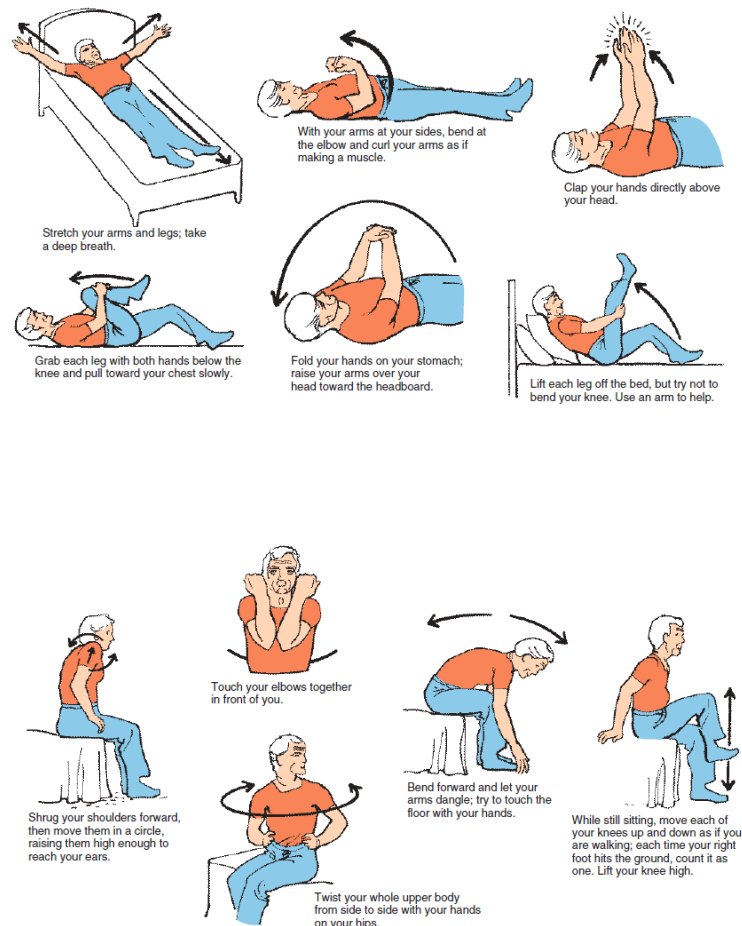
Menurut definisinya, pengekangan membatasi mobilitas. Perangkat apa pun yang membatasi mobilitas adalah pengekangan, termasuk rompi, meja kursi roda, pedal kaki, dan bahkan bar pengaman. Banyak dari perangkat ini yang secara historis telah digunakan untuk melindungi lansia karena jatuh sebenarnya meningkatkan kemungkinannya cedera. Lansia yang menggunakan perangkat ini dapat kehilangan kekuatan sendi dan otot dan fungsinya serta menjadi semakin rentan terhadap cedera. Pastikan belat atau perangkat lain tidak membatasi sambungan secara berlebihan pergerakan.

- f. Konsultasikan dengan ahli terapi fisik untuk menentukan rencana aktivitas/latihan yang sesuai dan dipertahankan kekuatan otot dan mobilitas sendi. Terapis fisik mungkin dapat menyarankan latihan yang bermanfaat bagi individu lansia tertentu. Latihan-latihan ini harus menjadi bagian dari rencana asuhan keperawatan dan dimasukkan dalam kegiatan hari itu (Gambar 1). Latihan rentang gerak pasif membantu menjaga sendi-sendi lansia tetap fleksibel, tetapi tidak banyak berperan dalam mempertahankan otot kekuatan. Rentang gerak pasif harus dilakukan minimal dua kali sehari bagi yang lansia yang tidak dapat bergerak.

Rentang gerak aktif membantu dengan fleksibilitas sendi dan tonus otot. Lansia dengan hemiplegia atau hemiparesis diajarkan untuk menggunakan sisi tubuh yang lebih kuat untuk melatih ekstremitas yang lebih lemah. Banyak fasilitas yang menyediakan program olah raga yang disesuaikan untuk memenuhi tingkat kemampuan lansia. Latihan sering dilakukan untuk musik karena ritmenya mendorong untuk bergerak. Latihan isometrik, misalnya melakukan pengencangan dan mengendurkan otot-otot lengan, perut, atau bokong secara bergantian, mungkin bermanfaat bagi beberapa lanjut usia dalam membantu menjaga kekuatan perut dan otot gluteal dan paha depan. Tetapi Latihan isometrik tidak memengaruhi persendian. Latihan isotonik, dapat membantu meningkatkan kekuatan otot, otot nadi, dan mobilitas sendi, termasuk gerakan-gerakan tersebut seperti mengangkat tubuh dari tempat tidur dengan trapeze, menekan alas kaki, atau mendorong tempat tidur untuk mengangkat bokong kasur. Latihan isometrik dan isotonik harus digunakan dengan hati-hati oleh lansia dengan masalah jantung karena latihan ini meningkat stres pada sistem kardiovaskular. Latihan-latihan ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan penggunaan manuver Valsava, yang bisa memperlambat detak jantung secara berbahaya, bahkan sampai pada titik tertentu serangan jantung pada seseorang dengan penyakit jantung. Untuk mencegah masalah ini, lansia harus diinstruksikan untuk bernapas melalui mulut sambil berolahraga.

- g. Pastikan bahwa lansia sudah berpakaian yang tepat untuk beraktivitas dan memiliki alas kaki yang sesuai. Pakaian dan alas kaki yang tepat harus dipilih untuk berolahraga. Anjurkan penggunaan sepatu bila memungkinkan. Sepatu harus pas dan menopang kaki untuk mengurangi kemungkinan terjatuh. Lansia wanita, khususnya yang memiliki kyphosis, sebaiknya dianjurkan memakai sepatu hak rendah saat berjalan untuk memberikan keseimbangan yang lebih baik.

Gambar 1. Latihan fisik lansia



E. Penutup

Jumlah lansia yang semakin meningkat dapat menyebabkan penurunan kesehatan, kesejahteraan dan kualitas hidup apabila tidak menerapkan pola hidup sehat. Aktivitas fisik memberikan berbagai manfaat pada kesehatan seperti penurunan angka kematian akibat penyakit kardiovaskular, kejadian hipertensi, kejadian kanker, kejadian diabetes tipe-2, pengurangan gejala kecemasan dan depresi, kesehatan kognitif, dan kualitas tidur; serta penurunan lemak tubuh. Aktivitas fisik pada lansia dapat membantu mencegah jatuh dan cedera akibat jatuh serta penurunan kesehatan tulang dan kemampuan fungsional. Perawat berperan

dalam memberikan asuhan keperawatan dengan tujuan antara lain meningkatkan partisipasi aktivitas fisik dengan menjaga kekuatan dan mobilitas, mempertahankan posisi dan fungsi anatomi normal secara keseluruhan, bebas dari kontraktur sendi dan *foot drop*, mempertahankan atau meningkatkan kekuatan dan mobilitas menggunakan alat bantu, menunjukkan peningkatan kemampuan untuk bertoleransi kegiatan, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap intoleransi aktivitas. Intervensi keperawatan yang dapat direkomendasikan karena terbukti mempunyai pengaruh terhadap keseimbangan dan mobilitas lansia adalah Latihan keseimbangan, *Ankle Strategy Exercise*, Senam lansia, Latihan ROM aktif, Senam kebugaran lansia, dan *Foam Rolling exercise*.

Referensi

- Adrian, K. (2023). Berbagai Jenis Olahraga Untuk Lansia Beserta Manfaatnya. <https://www.alodokter.com/olah-tubuh-bagi-lansia>
- Andria et al. (2021). Peningkatan Keseimbangan Tubuh Lansia Melalui Senam di Sebuah Balai Pelayanan dan Penyantunan Lansia. *Jurnal Keperawatan Rafflesia*, Volume 2 Nomor 2, November 2020 DOI 10.33088/jkr.v2i2.424.
- Anuar R., Imani D.R. & Norlinta S.N.O. (2021). Pengaruh Latihan Fisik Terhadap Kebugaran Lansia Dalam Masa Pandemi Covid-19: Narrative Review. *Fisiomu*.2021 Vol 2(2): 95-106 DOI: 10.23917/fisiomu.v2i2.13978
- Ayatullah. (2022). Pengaruh Balance Exercise (Latihan Keseimbangan) Terhadap Resiko Jatuh pada Lansia di BSLU Meci Angi Kota Bima. *Barongko Jurnal Ilmu Kesehatan* vol.1.No.3. Juli 2023.
- Azizah et al. (2025). Pengaruh Balance exercise Terhadap Tingkat Keseimbangan Lansia. *Citra Delima: Scientific Journal of Citra International Institute* Vol. 8 No. 2 (2025). DOI: <https://doi.org/10.33862/citradelima.v8i2.453>
- CDC. (2023). *Older Adult Activity: An Overview*. <https://www.cdc.gov/physical-activity-basics/guidelines/older-adults.html>
- Hasanah, N., Widhowati, S.S., Nugroho, S.T., Nahdliyah, A.I., Ikbali, D.K., Baniyati, N.A.T. (2023). Latihan Fisik Pada Kelompok Lansia Di Puskesmas Mulyoharjo Pemalang. *Calory Journal* - Volume 1, No. 4, 2023.
- Khaerunisa. (2021). Pengaruh Latihan Aktivitas Fisik Terhadap Keseimbangan Dinamis Pada Lansia: Narrative Review. [https://digilib.unisayogya.ac.id/6362/1/NASKAH%20PUBLIKASI%20ALDA%20KHAERUNISA 1810301025%20-%20Alda%20Khaerunisa.pdf?utm_source=chatgpt.com](https://digilib.unisayogya.ac.id/6362/1/NASKAH%20PUBLIKASI%20ALDA%20KHAERUNISA%201810301025%20-%20Alda%20Khaerunisa.pdf?utm_source=chatgpt.com)
- Kemenkes RI. (2024). Indonesia *Siapkan Lansia Aktif Dan Produktif*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis->

media/20240712/2145995/indonesia-siapkan-lansia-aktif-dan-produktif/#:~:text=Berdasarkan%20Sensus%20Penduduk%20Indonesia%20pada,penduduk%20Indonesia%20masuk%20kategori%20lansia.

Kurniadi, A.L. (2024). *Olahraga Yang Tepat Untuk Lansia : Menjaga Kesehatan dan Kualitas Hidup*. <https://rsa.ugm.ac.id/olahraga-yang-tepat-untuk-lansia-menjaga-kesehatan-dan-kualitas-hidup/>

Permana, B., Supriatin, E. S., Nurhayati, N., & Lindayani, L. (2022). Efektivitas Ankle Strategy Exercise Terhadap Keseimbangan Postural Pada Lansia Dengan Resiko Jatuh: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, 8(1), 122–130. <https://doi.org/10.33023/jikep.v8i1.936>

Sari, A. S., Wibowo, A. T., & Gupita, E. C. (2020). Sosialisasi Menjaga Kebugaran Jasmani saat Pandemi Covid-19 pada Sekolah Keterbakatan Olahraga Tingkat SMA di Kabupaten Kulonprogo. *Jurnal Bina Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–7.

Savitri, (2020). *Pengaruh Foam Rolling Exercise Dan Neuro Mobilisasi Terhadap Fleksibilitas Hamstring Pada Lansia : Narrative Review*. https://digilib.unisayogya.ac.id/5652/1/kadek%20mita%20bella%20savitri-1610301119-fisioterapi%20S1%20-%20Mitha%20Bella.pdf?utm_source=chatgpt.com

Setyorini, A., & Setyaningrum, N. (2019). Pengaruh Latihan Range of motion (Rom) Aktif Assitif Terhadap Rentang Gerak Sendi Pada Lansia Yang Mengalami Immobilisasi Fisik. *Surya Medika: Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Dan Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 13(2), 77–84. <https://doi.org/10.32504/sm.v13i2.116>

Shalma, N.K. (2025). *Usia Harapan Hidup Penduduk di Indonesia Meningkat: Bagaimana Cara Hidup Panjang dengan Sehat dan Sejahtera?* <https://ayosehat.kemkes.go.id/usia-harapan-hidup-penduduk-di-indonesia-meningkat-bagaimana-cara-hidup-panjang-dengan-sehat-dan-sejahtera>

Suciana, F., Handayani S., dan Ramadhani I. N. (2018). Pengaruh Senam Bugar Lansia

Terhadap Penurunan Resiko Jatuh Pada Lansia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*. XI(I):313–320.

Sunarti, & Silalahi, R. D. (2018). Pengaruh ROM Aktif Terhadap Kemampuan Mobilisasi Pada Lansia Arthritis Reumatoid di Rumah Bahagia Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Kepri.

Syapitri H. (2016). Pengaruh Latihan Swiss Ball Terhadap Keseimbangan Untuk Mengurangi Risiko Jatuh Pada Lansia Di UPT Pelayanan Sosial. *Jurnal INJEC*. 1(2):165–172.

Touhy, T.A & Jett, K.F. (2014). *Ebersole And Hess' Gerontological Nursing And Healthy Aging 4th Ed*. St. Louis: Elsevier

Williams, Patricia. (2016). Basic Geriatric Nursing 6th Edition. St. Louis: Elsevier

WHO. (2020). *WHO Guidelines On At A Glance Physical Activity And Sedentary Behaviour: At A Glance*.

Yantina, Y., & Saputri, A. (2019). Pengaruh Senam Lansia Terhadap Tekanan Darah Pada Wanita Lansia Dengan Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Banjarsari Metro Utara Tahun 2018. *Jurnal Farmasi Malahayati*, 2(1), 112–121.

Glosarium

G

GERMAS: adalah Gerakan Masyarakat Sehat

R

ROM: adalah Range of Motion

W

WHO: adalah World Health Organization

BAB III

KOLABORASI KOMUNITAS UNTUK MENCIPTAKAN PROGRAM KEBUGARAN LANSIA

A. Pendahuluan

Penuaan adalah proses alami yang dialami setiap individu. Seiring bertambahnya usia, lansia menghadapi berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka. Salah satu tantangan utama dalam penuaan adalah menurunnya kebugaran fisik, yang dapat berdampak pada mobilitas, kemandirian, dan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga kebugaran fisik menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan lansia.

Dalam upaya menciptakan lansia yang sehat dan aktif, keterlibatan komunitas menjadi faktor kunci. Komunitas, yang meliputi keluarga, organisasi sosial, fasilitas kesehatan, serta pemerintah dan sektor swasta, memiliki peran strategis dalam mendukung program kebugaran lansia. Melalui kolaborasi yang efektif, komunitas dapat menyediakan akses ke fasilitas olahraga, kegiatan sosial yang aktif, serta edukasi kesehatan yang mendorong lansia untuk tetap bergerak dan menjalani gaya hidup sehat.

Bab ini akan membahas bagaimana kolaborasi komunitas dapat menciptakan dan mengembangkan program kebugaran bagi lansia. Pembahasan mencakup peran komunitas dalam menjaga kebugaran lansia, strategi kolaborasi yang dapat diterapkan, model program yang telah sukses dijalankan, serta tantangan dan solusi dalam implementasinya. Dengan adanya sinergi antar berbagai elemen dalam komunitas, diharapkan program kebugaran lansia dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi lansia di berbagai lingkungan.

B. Peran Komunitas dalam Kebugaran Lansia

Lansia sering menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kebugaran fisik, termasuk keterbatasan mobilitas, kurangnya akses ke fasilitas olahraga, serta minimnya dukungan sosial. Oleh karena itu, komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kebugaran lansia. Dengan adanya keterlibatan komunitas, lansia dapat lebih mudah mengakses berbagai program kebugaran, mendapatkan edukasi kesehatan, serta memperoleh dukungan sosial yang dapat memperbaiki kualitas hidup lansia.

Salah satu cara utama komunitas membantu lansia dalam menjaga kebugaran adalah dengan menjadi fasilitator aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang terstruktur dapat membantu lansia mempertahankan kekuatan otot, keseimbangan tubuh, serta kesehatan jantung dan pernapasan. Komunitas dapat menyelenggarakan berbagai program aktivitas fisik, seperti:

1. Senam Lansia

Senam lansia adalah salah satu bentuk latihan yang populer di kalangan lansia karena gerakannya ringan, mudah diikuti, dan dapat disesuaikan dengan kondisi fisik peserta. Komunitas sering kali bekerja sama dengan puskesmas atau instruktur kebugaran untuk mengadakan senam lansia di balai desa, taman, atau pusat komunitas.

2. Yoga untuk Lansia

Yoga merupakan bentuk latihan yang mengutamakan pernapasan, keseimbangan, dan fleksibilitas. Bagi lansia, yoga dapat membantu mengurangi nyeri sendi, meningkatkan postur tubuh, serta mengurangi stres. Komunitas yang aktif dalam bidang kesehatan sering kali menyediakan sesi yoga bagi lansia dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kemampuan mereka.

3. Jalan Sehat dan Kegiatan Fisik Lainnya

Selain senam dan yoga, komunitas juga dapat mengorganisir kegiatan seperti jalan sehat bersama, tai chi, atau bahkan olahraga ringan seperti bulu tangkis dan tenis meja. Program ini tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik tetapi

juga memberikan kesempatan bagi lansia untuk bersosialisasi dan menghindari isolasi sosial.

Selain memfasilitasi aktivitas fisik, komunitas juga berperan sebagai pusat edukasi kesehatan bagi lansia. Edukasi ini sangat penting agar lansia memahami bagaimana cara menjaga kesehatan mereka secara mandiri. Beberapa program edukasi yang dapat dijalankan oleh komunitas antara lain:

1. Penyuluhan Pola Hidup Sehat

Komunitas dapat mengadakan sesi edukasi tentang pentingnya pola hidup sehat, termasuk pentingnya tidur yang cukup, menjaga kebersihan diri, serta menghindari kebiasaan buruk seperti merokok atau konsumsi alkohol.

2. Edukasi Gizi Seimbang untuk Lansia

Lansia memerlukan asupan gizi yang seimbang untuk menjaga kesehatan mereka. Komunitas dapat mengundang ahli gizi atau tenaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan tentang makanan sehat yang sesuai dengan kebutuhan lansia, termasuk makanan tinggi serat, rendah garam, dan kaya akan kalsium serta vitamin D.

3. Manajemen Penyakit Kronis

Banyak lansia menderita penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan osteoporosis. Komunitas dapat memberikan edukasi tentang cara mengelola penyakit ini, seperti pentingnya pemeriksaan rutin, konsumsi obat yang sesuai, serta perubahan gaya hidup yang dapat membantu mengurangi risiko komplikasi.

4. Pelatihan Pertolongan Pertama dan Pencegahan Cedera

Lansia lebih rentan terhadap jatuh dan cedera. Oleh karena itu, komunitas dapat mengadakan pelatihan tentang cara mencegah jatuh, mengenali tanda-tanda stroke atau serangan jantung, serta memberikan pelatihan pertolongan pertama bagi lansia dan keluarganya.

Selain aspek fasilitator aktivitas fisik dan edukasi kesehatan, komunitas juga memiliki peran penting sebagai penyedia dukungan sosial bagi lansia. Dukungan

sosial yang kuat dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional lansia serta membantu lansia merasa lebih dihargai dan diakui dalam masyarakat. Beberapa bentuk dukungan sosial yang dapat diberikan oleh komunitas meliputi:

1. Membentuk Kelompok Pendukung Lansia

Komunitas dapat membentuk kelompok diskusi atau kelompok pendukung lansia yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi lansia dalam berbagi pengalaman, mendiskusikan tantangan yang dihadapi, serta saling memberi semangat.

2. Program Relawan Lansia

Komunitas dapat mengorganisir program relawan di mana lansia yang masih aktif dapat membantu lansia lain yang lebih rentan atau membutuhkan bantuan, seperti memberikan pendampingan, membantu belanja kebutuhan sehari-hari, atau sekadar menemani berbincang.

3. Meningkatkan Interaksi Antar Generasi

Program yang melibatkan anak muda dalam berinteraksi dengan lansia, seperti program "sahabat lansia" atau kegiatan sosial lintas generasi, dapat memberikan manfaat besar bagi lansia dengan memberikan rasa dihargai dan diakui dalam komunitas.

4. Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Rekreasi

Selain program kesehatan dan olahraga, komunitas juga dapat menyelenggarakan kegiatan rekreasi seperti piknik, wisata religi, atau perayaan hari besar yang melibatkan lansia. Kegiatan ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan lansia.

Komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kebugaran fisik lansia melalui tiga aspek utama, yaitu sebagai fasilitator aktivitas fisik, sebagai pusat edukasi kesehatan, dan sebagai penyedia dukungan sosial. Dengan adanya kolaborasi antara komunitas, tenaga kesehatan, pemerintah, dan keluarga, lansia dapat menjalani hidup yang lebih sehat, aktif, dan sejahtera.

C. Strategi Kolaborasi dalam Program Kebugaran Lansia

Agar program kebugaran lansia dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk institusi kesehatan, pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, serta keluarga. Setiap pihak memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung lansia untuk tetap aktif, sehat, dan memiliki kualitas hidup yang baik.

Kolaborasi dengan Institusi kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik memiliki peran utama dalam memastikan bahwa program kebugaran lansia berjalan dengan berbasis pada prinsip-prinsip kesehatan yang tepat. Kolaborasi ini melibatkan berbagai aspek, seperti:

1. **Pemeriksaan Kesehatan Berkala**

Sebelum lansia mengikuti program kebugaran, mereka perlu menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa aktivitas fisik yang dilakukan sesuai dengan kondisi mereka. Puskesmas dan klinik dapat menyediakan layanan skrining kesehatan bagi lansia secara berkala.

2. **Edukasi dan Konsultasi Kesehatan**

Petugas kesehatan dapat memberikan penyuluhan terkait manfaat aktivitas fisik, cara menjaga pola makan sehat, serta cara mengelola penyakit kronis yang umum dialami lansia, seperti hipertensi, diabetes, dan osteoarthritis.

3. **Fisioterapi dan Rehabilitasi**

Lansia yang memiliki keterbatasan fisik dapat mendapatkan layanan fisioterapi di fasilitas kesehatan untuk membantu lansia tetap aktif secara aman dan nyaman.

4. **Pendampingan Medis dalam Kegiatan Kebugaran**

Institusi kesehatan dapat menyediakan tenaga medis atau paramedis dalam kegiatan kebugaran lansia untuk memastikan keselamatan lansia selama melakukan aktivitas fisik.

Kolaborasi dengan Pemerintah juga sangat diperlukan. Pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung kebugaran lansia melalui kebijakan dan program yang berbasis komunitas. Beberapa bentuk kolaborasi dengan pemerintah dalam program kebugaran lansia meliputi:

1. Penyediaan Fasilitas Publik untuk Aktivitas Lansia

Pemerintah daerah dapat membangun atau mengembangkan taman-taman kota, jalur pejalan kaki, serta fasilitas olahraga yang ramah lansia.

2. Program Senam Lansia di Tingkat Kelurahan dan Desa

Pemerintah dapat mendukung penyelenggaraan senam lansia secara rutin di tingkat RT/RW dengan menyediakan instruktur dan sarana yang memadai.

3. Subsidi dan Bantuan untuk Program Lansia

Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk program kesehatan lansia, seperti layanan konsultasi gratis, pemberian alat bantu kesehatan, serta bantuan makanan bergizi bagi lansia dengan keterbatasan ekonomi.

4. Integrasi Program Lansia dalam Rencana Pembangunan Daerah

Program kebugaran lansia harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah agar dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Selain kolaborasi dengan pemerintah dan institusi kesehatan, **kolaborasi dengan organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)** serta sektor swasta juga berperan penting dalam mendukung kebugaran lansia dengan menyediakan sumber daya dan fasilitas. Kolaborasi ini dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Dukungan Pendanaan dan Sponsor Kegiatan

Perusahaan swasta dapat memberikan bantuan dana atau menjadi sponsor dalam penyelenggaraan program kebugaran lansia, seperti kompetisi olahraga lansia atau program latihan berkala yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi lansia.

2. Pelatihan bagi Relawan dan Instruktur

LSM yang bergerak di bidang kesehatan dapat mengadakan pelatihan bagi relawan atau instruktur kebugaran untuk membekali mereka dengan pengetahuan tentang kebugaran lansia.

3. Penyediaan Fasilitas dan Peralatan Olahraga

Beberapa perusahaan dapat menyumbangkan peralatan olahraga yang ramah lansia, seperti matras yoga, kursi senam, atau alat bantu jalan yang ergonomis.

4. Kemitraan dengan Perusahaan Teknologi Kesehatan

Inovasi teknologi, seperti aplikasi pemantauan kesehatan atau perangkat kebugaran digital, dapat dimanfaatkan untuk membantu lansia dalam menjalani gaya hidup aktif secara lebih aman dan terukur.

Kolaborasi dengan keluarga juga tidak kalah pentingnya. Dukungan keluarga sangat penting dalam mendorong lansia untuk tetap aktif dan berpartisipasi dalam program kebugaran. Keluarga dapat berkontribusi dalam berbagai cara, seperti:

1. Motivasi dan Pendampingan

Anggota keluarga dapat memberikan dukungan emosional dengan mendorong lansia untuk mengikuti aktivitas fisik secara rutin serta menemani mereka dalam kegiatan olahraga.

2. Penerapan Gaya Hidup Sehat di Rumah

Keluarga dapat menciptakan lingkungan rumah yang mendukung kesehatan lansia, misalnya dengan menyajikan makanan sehat, menyediakan ruang untuk olahraga ringan, serta membatasi konsumsi gula dan garam dalam makanan sehari-hari.

3. Penggunaan Teknologi untuk Pemantauan Kesehatan

Keluarga dapat membantu lansia menggunakan aplikasi pemantauan kebugaran, seperti pedometer atau smartwatch, agar mereka dapat mengetahui perkembangan aktivitas fisiknya.

4. Membantu Mengakses Fasilitas Kebugaran

Beberapa lansia mengalami keterbatasan mobilitas yang membuat mereka sulit untuk berpartisipasi dalam program kebugaran. Keluarga dapat membantu dengan menyediakan transportasi atau mendampingi mereka saat menghadiri kegiatan di komunitas.

Keberhasilan program kebugaran fisik bagi lansia bergantung pada sinergi antara berbagai pihak, termasuk institusi kesehatan, pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan keluarga. Kolaborasi yang kuat dapat memastikan bahwa lansia mendapatkan akses ke aktivitas fisik yang sesuai, edukasi kesehatan yang memadai, serta dukungan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, lansia dapat menjalani hidup yang lebih sehat, aktif, dan produktif di usia senja lansia.

D. Model Program Kebugaran Lansia Berbasis Komunitas

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup lansia, berbagai program kebugaran lansia berbasis komunitas telah dikembangkan dengan pendekatan inovatif dan inklusif. Program ini juga dirancang untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial para lansia melalui berbagai pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia. Model program ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan teknologi untuk meningkatkan partisipasi lansia yang mendukung kebugaran lansia secara holistik. Beberapa model program yang dapat diterapkan di komunitas meliputi:

1. Program Senam dan Seni: Inovasi dalam Aktivitas Fisik Lansia

Program senam dan seni melalui inovasi dalam aktivitas fisik ini menggabungkan aktivitas fisik dengan elemen seni tradisional sebagai pendekatan inovatif untuk meningkatkan minat dan partisipasi lansia dalam kegiatan menjaga kebugaran. Program ini meliputi:

a. Senam lansia berbasis budaya

Melalui senam lansia berbasis budaya yang mengintegrasikan unsur seni tradisional, seperti tari daerah atau musik gamelan, dalam sesi senam lansia.

Contoh program yang sudah diterapkan adalah senam poco-poco, tari line dance, dan senam dengan musik keroncong yang lebih familiar bagi lansia. Pendekatan ini membuat aktivitas lebih menyenangkan dan meningkatkan motivasi lansia untuk rutin berolahraga.

b. Terapi seni untuk lansia

Terapi seni ini akan mengkombinasikan gerakan tubuh dengan terapi seni, seperti seni lukis atau musik, yang dapat merangsang kognisi serta mengurangi risiko demensia pada lansia. Lansia yang memiliki keterbatasan fisik dapat berpartisipasi dalam aktivitas seni yang tetap memberikan manfaat kebugaran, seperti seni gerak tangan atau terapi musik dengan menari di tempat.

Program senam dan seni yang dilakukan dengan pendekatan inovatif dalam aktivitas fisik, akan memberikan banyak **manfaat bagi lansia, antara lain:** meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh lansia untuk mencegah atau menurunkan risiko jatuh. Selain itu dapat meningkatkan interaksi sosial, terutama melalui kegiatan yang melibatkan kelompok. Yang paling utama adalah dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental melalui ekspresi seni.

2. Program Berbasis Olahraga

Aktivitas fisik memiliki peran penting dalam menjaga kebugaran lansia dan meningkatkan mobilitas fisik, serta mencegah berbagai penyakit degeneratif akibat pertambahan usia. Beberapa program berbasis olahraga yang dapat diterapkan dalam komunitas meliputi:

- a) Senam Lansia.** Senam lansia merupakan salah satu bentuk latihan fisik yang paling populer karena mudah diikuti dan memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan keseimbangan, fleksibilitas, serta kesehatan jantung. Biasanya dilakukan secara berkelompok di pusat komunitas, taman, atau fasilitas kesehatan.

- b) Yoga untuk Lansia.** Yoga dapat membantu meningkatkan kelenturan, keseimbangan, dan ketenangan pikiran. Gerakan yoga dapat dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi fisik lansia, termasuk yoga kursi bagi lansia yang memiliki keterbatasan dalam mobilitas fisik.
- c) Jalan Sehat.** Aktivitas fisik yang dilakukan dengan berjalan kaki secara rutin dapat meningkatkan kesehatan kardiovaskular dan menjaga berat badan ideal. Program ini dapat dikombinasikan dengan interaksi sosial, misalnya dengan membentuk kelompok jalan sehat di lingkungan tempat tinggal lansia.
- d) Tai Chi.** Latihan Tai Chi merupakan latihan fisik yang menggabungkan gerakan lambat dan pernapasan terkontrol yang bermanfaat untuk keseimbangan, koordinasi, dan relaksasi. Terbukti efektif dalam mengurangi risiko jatuh dan meningkatkan kesehatan mental lansia.

3. Program Berbasis Aktivitas Sosial

Interaksi sosial sangat penting bagi kesejahteraan lansia untuk mencegah isolasi dan meningkatkan kesehatan mental. Program berbasis aktivitas sosial meliputi: 1) klub atau perkumpulan lansia; 2) kegiatan rekreasi aktif; 3) kelompok dukungan lansia.

Klub lansia atau perkumpulan atau paguyuban lansia berfungsi sebagai wadah untuk berkumpul, berbagi pengalaman, dan mengikuti berbagai kegiatan yang mendukung kesehatan dan kebahagiaan lansia. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan diskusi tentang kesehatan, seni, musik, atau permainan yang merangsang kognisi.

Kegiatan rekreasi aktif dapat dilakukan dengan cara melibatkan lansia dalam aktivitas rekreasi seperti berkebun, menari, atau berwisata sehat. Aktivitas rekreasi aktif ini dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan memberikan hiburan yang positif.

Kelompok Dukungan Lansia merupakan kelompok yang berfungsi sebagai wadah bagi lansia untuk berbagi pengalaman dan memberikan

dukungan emosional terhadap sesama lansia dengan kondisi atau karakteristik yang sama. Kelompok ini dapat berfokus pada tema tertentu, seperti kelompok lansia penderita diabetes melitus atau hipertensi yang saling mendukung dalam manajemen penyakit.

4. Program Berbasis Pendidikan

Edukasi berperan penting dalam meningkatkan kesadaran lansia terhadap pola hidup sehat dan manajemen kesehatan. Program berbasis pendidikan yang dapat diterapkan meliputi: edukasi gizi untuk lansia, **manajemen penyakit kronis dan upaya kesehatan mental untuk lansia.**

Edukasi Gizi untuk Lansia dilakukan dengan memberikan informasi tentang pola makan seimbang, kebutuhan nutrisi yang sesuai dengan usia, serta cara mengelola diet untuk kondisi tertentu seperti diabetes atau hipertensi. Dalam melakukan **Manajemen Penyakit Kronis, lansia dibelajarkan** tentang cara mengelola penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan osteoporosis melalui kombinasi pola makan atau diet sehat, olahraga atau aktivitas fisik, dan pengobatan yang tepat. Tentunya kegiatan pengelolaan penyakit kronis ini, perlu melibatkan tenaga kesehatan seperti dokter atau ahli gizi untuk memberikan informasi yang valid dan akurat. Pada aspek upaya **Kesehatan Mental untuk Lansia dilakukan dengan** memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, cara mengelola stres, dan pencegahan demensia, dengan menghadirkan melibatkan psikolog atau tenaga profesional untuk mendukung lansia dalam menjaga kesehatan mental lansia.

5. Pemanfaatan Teknologi dalam Program Kebugaran Lansia

Teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung kebugaran lansia, terutama bagi lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas atau keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Beberapa inovasi teknologi yang dapat digunakan meliputi:

a) Aplikasi Kesehatan

Aplikasi seperti *Google Fit*, *MyFitnessPal*, dan *Sworkit Senior Workout* dapat membantu lansia memantau aktivitas fisik, detak jantung, dan pola makan lansia. Aplikasi ini juga dapat memberikan rekomendasi latihan yang sesuai dengan kondisi fisik lansia.

b) Telemedicine dan Konsultasi Online

Layanan telemedicine memungkinkan lansia berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Membantu lansia mendapatkan informasi medis yang valid serta rekomendasi aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi mereka.

c) Media Sosial dan Komunitas Virtual

Lansia dapat bergabung dalam komunitas daring melalui media sosial seperti Facebook atau WhatsApp untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan informasi kesehatan.

d) Virtual fitness dan senam online

Program kebugaran seperti senam atau yoga lansia dapat diadakan secara daring melalui platform seperti Zoom atau YouTube agar lebih mudah diakses dari rumah. Memungkinkan lansia yang tidak dapat hadir secara fisik tetap dapat mengikuti program kebugaran dari rumah.

6. Program Posyandu Lansia: Inisiatif Kesehatan dan Sosial Berbasis Komunitas

Posyandu Lansia merupakan program berbasis komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan lansia melalui pendekatan preventif dan promotif. Program ini biasanya dikelola oleh kader kesehatan di tingkat desa atau kelurahan dengan dukungan dari puskesmas, dimana petugas puskesmas akan hadir untuk memberi pelayanan kesehatan pada saat kegiatan posyandu berlangsung yang diselenggarakan pada setiap periode waktu yang sudah disepakati bersama, misalnya setiap bulan atau setiap 2 bulan.

Bentuk **Pelayanan Kesehatan di Posyandu Lansia** antara lain berupa pemeriksaan kesehatan rutin, seperti pengukuran tekanan darah, kadar gula

darah, dan indeks massa tubuh. Hasil pengukuran dan pemeriksaan kesehatan menjadi pencatatan data kesehatan oleh kader. Edukasi kesehatan tentang pola makan sehat, pencegahan penyakit kronis, dan pentingnya aktivitas fisik.

Dalam program kegiatan posyandu, bentuk **Kegiatan Sosial dan Kebugaran Lansia berupa** senam lansia yang dilakukan secara rutin sebagai bagian dari kegiatan posyandu. Selain itu, pembentukan kelompok diskusi dan sesi berbagi pengalaman pada sesama lansia untuk meningkatkan dukungan sosial, juga penting untuk dilakukan.

Kader Kesehatan memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan program posyandu Lansia, dimana kader melakukan pendampingan bagi lansia dalam menjalankan gaya hidup sehat di kehidupan sehari-hari, dan selalu mendorong lansia untuk tetap aktif dengan mengorganisir kegiatan olahraga ringan secara rutin.

Dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kader sebagai **inisiatif kesehatan dan sosial berbasis komunitas, maka manfaat program posyandu lansia yang dapat dirasakan adalah:**

- Meningkatkan akses lansia terhadap layanan kesehatan di tingkat komunitas.
- Memperkuat hubungan sosial dan mencegah isolasi sosial pada lansia.
- Mengurangi beban keluarga dalam merawat lansia dengan menyediakan dukungan komunitas yang berkelanjutan.

Model program kebugaran lansia berbasis komunitas harus dirancang secara inovatif dan inklusif agar lansia dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesehatannya. Model program kebugaran lansia berbasis komunitas yang berkelanjutan harus mencakup berbagai aspek, mulai dari aktivitas fisik, interaksi sosial, edukasi, hingga pemanfaatan teknologi agar dapat diterapkan secara efektif dan inklusif. Kombinasi antara aktivitas fisik, seni, teknologi, dan pendekatan

berbasis komunitas seperti Posyandu Lansia dapat menjadi strategi efektif dalam menciptakan program kebugaran bagi lansia.

Program berbasis olahraga/aktivitas fisik membantu meningkatkan kebugaran fisik, sementara program berbasis aktivitas sosial mencegah isolasi dan meningkatkan kesejahteraan mental. Selain itu, edukasi gizi dan manajemen penyakit kronis berperan dalam meningkatkan pemahaman lansia terhadap kesehatan diri lansia. Dengan dukungan teknologi, lansia dapat tetap terlibat dalam program kebugaran meskipun memiliki keterbatasan mobilitas.

Melalui pendekatan yang holistik ini, diharapkan komunitas dapat menciptakan lingkungan yang ramah lansia dan mendukung lansia untuk dapat menjalani hidup yang lebih sehat, aktif, mandiri, bahagia dan berkualitas.

E. Implementasi dan Tantangan Kolaborasi Komunitas dalam Program

Kebugaran Lansia

Kolaborasi komunitas dalam menciptakan program kebugaran lansia memerlukan perencanaan yang matang dan keterlibatan berbagai pihak, seperti institusi kesehatan, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan keluarga. Meskipun memiliki banyak manfaat, pelaksanaan program ini menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi dengan strategi yang tepat.

1. **Langkah-langkah Implementasi program kebugaran lansia** berbasis komunitas terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu: a) Perencanaan Program; b) Pelaksanaan Program; dan c) Evaluasi Program.

Tahap Perencanaan Program ini melibatkan identifikasi kebutuhan lansia, sumber daya yang tersedia, serta perencanaan strategi pelaksanaan. Langkah-langkah perencanaan mencakup: **Identifikasi kebutuhan lansia** yang dilakukan melalui pengadaan survei atau wawancara dengan lansia untuk memahami preferensi dan tantangan yang dihadapi lansia dalam berpartisipasi di kegiatan kebugaran. **Penentuan jenis program** juga penting untuk memilih program yang sesuai dengan kondisi fisik dan sosial lansia, seperti senam lansia, yoga,

atau edukasi kesehatan. Selain itu, **Kolaborasi dengan pemangku kepentingan** dengan cara melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan organisasi sosial dalam perencanaan agar program lebih komprehensif.

Pada tahapan Pelaksanaan Program kebugaran lansia mulai dijalankan dengan mempertimbangkan efektivitas dan partisipasi lansia. Beberapa aspek penting dalam pelaksanaan adalah: 1) Pelatihan fasilitator atau kader kesehatan: dengan cara melatih tenaga pendamping atau kader yang akan memandu aktivitas kebugaran lansia; 2) Penyediaan sarana dan prasarana: dengan menyediakan tempat yang nyaman dan aman untuk kegiatan lansia, seperti taman, balai desa, atau pusat kesehatan; 3) Meningkatkan partisipasi lansia: melalui upaya membangun kesadaran melalui sosialisasi di lingkungan komunitas, media sosial, dan keterlibatan keluarga.

Tahap Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan program dan memastikan keberlanjutan program kebugaran lansia. Tahapan evaluasi dapat meliputi:

- Pengukuran dampak terhadap kesehatan lansia, dengan cara memantau perubahan dalam kebugaran fisik, seperti peningkatan keseimbangan, mobilitas, dan kebugaran jantung.
 - Umpan balik dari peserta, untuk itu perlu melakukan survei atau diskusi kelompok untuk memahami kepuasan lansia terhadap program.
 - Rekomendasi perbaikan, yang merupakan bagian penting agar mampu menyesuaikan program berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitasnya.
2. Tantangan yang dihadapi dalam Kolaborasi Komunitas. Implementasi program kebugaran lansia berbasis komunitas tidak lepas dari berbagai tantangan, diantaranya yaitu:
- **Keterbatasan Sumber Daya, terkait kolaborasi komunitas dalam penyelenggaraan program kebugaran lansia ditandai dengan minimnya dana untuk penyelenggaraan program dan pengadaan fasilitas**

olahraga bagi lansia; kurangnya tenaga pendamping atau kader yang terlatih dalam membimbing aktivitas fisik lansia; dan terbatasnya akses ke alat bantu teknologi bagi lansia yang ingin mengikuti program secara daring.

- **Rendahnya Partisipasi Lansia. Dikarenakan banyak** Lansia yang enggan berpartisipasi karena kurangnya kesadaran lansia tentang pentingnya kebugaran fisik juga terdapat hambatan fisik pada lansia, seperti keterbatasan mobilitas atau penyakit kronis, yang membuat lansia sulit mengikuti kegiatan kebugaran. Selain itu, faktor psikososial, seperti rasa malu atau kurangnya motivasi, yang mengurangi minat lansia dalam kegiatan kelompok.
- **Keberlanjutan Program, merupakan tantangan besar yang harus dihadapi dalam program kolaborasi program kebugaran lansia ini.** Program ini termasuk program yang bergantung pada dukungan sementara dari sponsor atau lembaga tertentu sehingga sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Kurangnya regulasi atau kebijakan yang mendukung integrasi program kebugaran lansia dalam sistem kesehatan dan sosial masyarakat, juga menjadi tantangan kolaborasi komunitas untuk program kebugaran lansia

3. Solusi dan Rekomendasi untuk mengatasi tantangan kolaborasi komunitas dalam program kebugaran lansia. Agar program kebugaran lansia berbasis komunitas dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan berbagai solusi strategis, di antaranya:

- a. **Pelatihan Kader dan Relawan.** Mengadakan pelatihan bagi kader kesehatan, tenaga pendamping, dan relawan untuk membimbing lansia dalam program kebugaran. Juga perlu untuk menyediakan insentif bagi kader untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam program.

- b. **Pendanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal. Dilakukan dengan upaya** membangun kemitraan dengan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk memperoleh dukungan finansial dan fasilitas. Mengoptimalkan sarana yang sudah ada, seperti posyandu lansia atau balai desa, untuk mengadakan kegiatan kebugaran tanpa perlu investasi besar.
- c. **Peningkatan Partisipasi Lansia dapat dilakukan dengan** menggunakan pendekatan berbasis komunitas, seperti melibatkan keluarga dalam mendukung lansia untuk mengikuti program. Menyesuaikan aktivitas kebugaran dengan kondisi fisik lansia, seperti menyediakan latihan dengan intensitas yang lebih ringan atau menggunakan teknologi untuk memfasilitasi kegiatan dari rumah. Mengadakan kampanye edukasi melalui media sosial atau komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat aktivitas fisik bagi lansia.
- d. **Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung, penting untuk dilakukan dengan** mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program kebugaran lansia dalam kebijakan kesehatan dan sosial. Mengadvokasi pengalokasian anggaran khusus untuk program lansia di tingkat komunitas. Meningkatkan sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial untuk mendukung keberlanjutan program.

Kolaborasi komunitas dalam program kebugaran lansia harus melalui tahapan yang sistematis dan mempertimbangkan berbagai tantangan yang mungkin muncul. Dengan pendekatan yang tepat, program ini dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lansia, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup lansia.

F. Penutup

Kebugaran fisik merupakan aspek krusial dalam menjaga kualitas hidup lansia. Aktivitas fisik yang teratur tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga

berdampak positif terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan sosial lansia. Program kebugaran yang berbasis komunitas menjadi solusi efektif dalam mendorong partisipasi lansia untuk tetap aktif, baik melalui olahraga, kegiatan sosial, maupun edukasi kesehatan.

Program kebugaran berbasis komunitas telah terbukti memberikan dampak positif bagi kualitas hidup lansia. Aktivitas fisik yang teratur membantu meningkatkan kesehatan fisik, mengurangi risiko penyakit kronis, serta memperbaiki keseimbangan dan mobilitas lansia. Selain itu, partisipasi dalam program komunitas juga berkontribusi terhadap kesejahteraan mental dan sosial, mencegah isolasi, serta meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian lansia.

Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk institusi kesehatan, pemerintah, organisasi non-pemerintah, keluarga, dan komunitas lokal, sangat penting dalam menciptakan program kebugaran yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi lansia, serta keberlanjutan program. Oleh karena itu, strategi yang melibatkan pelatihan kader, pemanfaatan teknologi, serta kebijakan yang mendukung perlu diterapkan agar program kebugaran lansia dapat berjalan efektif.

Dengan adanya kesadaran dan kerja sama dari berbagai pihak, diharapkan lansia dapat menikmati masa tua yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kebugaran fisik lansia harus terus didorong dan dikembangkan agar lansia tetap aktif, produktif, dan dapat meningkatkan kualitas hidup secara optimal.

Referensi

- Baez, M., Ibarra, F., Khaghani Far, I., Ferron, M., & Casati, F. (2016). *Online Group-exercises for Older Adults of Different Physical Abilities*.
- Burr, J. A., & Mutchler, J. E. (2017). *Volunteering and Hypertension Risk in Later Life*. *Journal of Aging and Health*, 19(1), 139–157.
- Caspersen, C. J., Powell, K. E., & Christenson, G. M. (2015). "Physical activity, exercise, and physical fitness: Definitions and distinctions for health-related research." *Public Health Reports*, 100(2), 126-131. <https://doi.org/10.1177/003335491510000202>.
- Chang, J., Yu, F., & Shen, W. (2020). "Effects of exercise interventions on frailty in community-dwelling older adults: A meta-analysis." *Ageing Research Reviews*, 64, 101185. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2020.101185>
- Chodzko-Zajko, W. J., et al. (2009). *Exercise and Physical Activity for Older Adults: Position Stand from the American College of Sports Medicine*. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 41(7), 1510–1530.
- Desa Cikoneng, Ciamis. (2024). *Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah: Membangun Kesehatan Lansia di Cikoneng, Ciamis*.
- Dinas Kesehatan Kota Metro. (2024). *Upaya Perkuat Kesehatan Lansia, Pemerintah Kota Metro Rumuskan Strategi Kolaboratif*.
- Gothe, N. P., & McAuley, E. (2016). "Yoga and cognition: A meta-analysis of chronic and acute effects." *Psychosomatic Medicine*, 78(7), 571-586. <https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000307>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Pedoman Pelaksanaan Program Kesehatan Lansia di Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.

- Lee, I.-M., Shiroma, E. J., Lobelo, F., Puska, P., Blair, S. N., & Katzmarzyk, P. T. (2018). "Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: An analysis of burden of disease and life expectancy." *The Lancet*, 380 (9838), 219-229. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)61031-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61031-9).
- Nelson, M. E. (2017). *Physical Activity and Public Health in Older Adults: Recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association*. *Circulation*, 116(9), 1094–1105.
- Phelan, E. A., et al. (2015). *Promoting and Maintaining Physical Activity in Older Adults*. *American Family Physician*, 91(6), 425–432.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Profil Kesehatan Lansia di Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Puts, M. T. E., Toubasi, S., Atkinson, E., Ayala, A. P., Andrew, M. K., Ashe, M. C., & McGilton, K. S. (2017). "Interventions to prevent or reduce the level of frailty in community-dwelling older adults: A scoping review of the literature." *Age and Ageing*, 46(3), 383–392. <https://doi.org/10.1093/ageing/afw247>.
- Rowe, J. W., & Kahn, R. L. (1997). *Successful Aging: The MacArthur Foundation Study*. *The Gerontologist*, 37(4), 433–440.
- Sherrington, C., Fairhall, N. J., Wallbank, G. K., Tiedemann, A., Michaleff, Z. A., Howard, K., & Lord, S. R. (2019). "Exercise for preventing falls in older people living in the community: An abridged Cochrane systematic review." *British Journal of Sports Medicine*, 54(15), 885-891. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-101512>.
- Tak, E., Kuiper, R., Chorus, A., & Hopman-Rock, M. (2019). "Prevention of onset and progression of basic ADL disability in community-dwelling older adults: A meta-analysis." *Ageing Research Reviews*, 55, 100947. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2019.100947>.
- Tinker, A., & Lansley, P. (2005). *Introducing Assistive Technology into the Existing*

Homes of Older People: Feasibility, Acceptability, Costs and Outcomes. Journal of Aging Studies, 19(1), 55–66.

Wisma Lansia Harapan Asri. (2024). *Peran Pekerja Sosial dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Wisma Lansia Harapan Asri.* Jurnal Unpad.

World Health Organization (WHO). (2020). *Physical activity and older adults: Recommendations and benefits.*

World Health Organization (WHO). (2020). *Global Recommendations on Physical Activity for Health: Ageing Population.* Geneva: WHO.

BAB IV

DUKUNGAN KELUARGA DALAM MENDUKUNG AKTIVITAS FISIK LANSIA

A. Pendahuluan

Lanjut usia atau lansia merupakan tahap akhir dari siklus hidup manusia, yaitu bagian dari proses kehidupan yang tak dapat dihindarkan. Setiap individu pasti akan mengalami siklus ini. Di Indonesia jumlah penduduk lansia semakin lama semakin meningkat sehingga disebut sebagai *fase ageing population*. Subekti (2022) dalam tulisannya menyatakan bahwa berdasar sensus penduduk Indonesia pada tahun 2023 jumlah penduduk lansia berkisar 29 juta (hampir 12 %) masuk kategori lansia.

Proses penuaan adalah proses seumur hidup yang dimulai tidak hanya pada periode tertentu, tetapi juga dari awal kehidupan. Karena proses penuaan, sel-sel memburuk di usia tua, yang dapat menyebabkan melemahnya organ, degenerasi fisik, dan pembentukan berbagai jenis penyakit degeneratif, menyebabkan masalah sosial, ekonomi, dan psikologis. Selain itu juga terjadi penurunan pada system kekebalan tubuh (Astuti, 2024).

Proses penuaan yang terjadi pada lansia tidak hanya mengenai usia yang bertambah namun juga disertai penurunan fungsi tubuh. Dengan adanya penurunan fungsi tubuh maka lansia akan sulit bergerak diakibatkan rasa sakit yang timbul karena proses penuaan ini. Hal ini mengakibatkan lansia memilih tinggal di tempat tidur dibandingkan melakukan aktivitas. Kondisi ini berangsur-angsur akan menyebabkan gangguan pada system musculoskeletal. Gejala yang sering muncul akibat adanya gangguan system musculoskeletal ini antara lain rasa nyeri, kaku pada persendian, otot terasa lunak hal ini menyebabkan lansia tidak nyaman untuk bergerak. Bahkan tidak jarang dijumpai kondisi tulang yang mudah patah pada lansia.

Gangguan pada musculoskeletal pada lansia dapat dipicu oleh beberapa factor. Factor pemicu ini antara lain factor usia, gangguan pada tulang belakang, memiliki penyakit tertentu dan riwayat cedera.

Gangguan lain yang juga dijumpai pada lansia antara lain gangguan system nervorum, system gastrointestinal, gangguan system cardiovascular, gangguan system metabolic maupun gangguan pada system pulmonal. Gangguan pada system ini pun juga dipengaruhi oleh gaya hidup, dan perilaku yang dilakukan oleh lansia.

Badan Statistik Indonesia (2024) menyatakan bahwa Indonesia saat ini memasuki era penduduk tua (*ageing population*). Indonesia memasuki era *ageing population* sejak tahun 2021. *Ageing population* merupakan terjadinya fenomena yang diakibatkan usia rata-rata penduduk disuatu wilayah atau negara meningkat dengan kata lain usia harapan hidup meningkat dan diikuti jumlah lansia yang meningkat pula (Sari, dkk, 2024).

(Sari dkk, 2024)

B. Keluarga Lansia dan Permasalahan Kesehatan pada Lansia

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga merupakan suatu kelompok orang sebagai suatu kesatuan atau unit yang terikat oleh pernikahan dan hubungan darah yang mengandung fungsi untuk memenuhi kebutuhan emosional anggotanya, serta dapat memberikan kesempatan untuk saling berinteraksi bagi anggotanya (Syarbini, 2016). Sedangkan keluarga lansia menurut BKKBN (2019) adalah keluarga yang memiliki salah satu atau beberapa anggota keluarganya yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Lanjut usia (Lansia) adalah periode dari usia 60 tahun sampai dengan meninggal yang ditandai adanya perubahan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain (Masril, Sari, and Natassa 2022).

Keluarga merupakan tempat berinteraksi antar anggotanya. Interaksi yang dibangun akan menimbulkan keterikatan emosi antar anggotanya. Untuk itu peran

keluarga lansia sangat dibutuhkan untuk mengenal permasalahan yang sering dihadapi pada lansia. Menurut BKKBN fungsi keluarga antara lain adalah memberikan rasa kasih sayang, perlindungan dan fungsi sosialisasi dan Pendidikan. Fungsi ini erat kaitannya dengan lansia.

Setiap lansia akan mengalami penuaan yang ditandai dengan terjadinya perubahan bentuk tubuh dan fungsi tubuh yang mulai menurun. Seiring bertambahnya usia maka hal-hal yang perlu diperhatikan oleh keluarga lansia antara lain kekurangan nutrisi, munculnya penyakit penerta, kemampuan berfikir yang mulai menurun bahkan tidak jarang dijumpai lansia yang mengalami dementia.

Gejala yang sering dijumpai pada lansia antara lain kurang bergerak, berdiri dan berjalan tidak stabil atau mudah jatuh, besar buang air kecil dan atau buang air besar, gangguan intelektual/dementia, infeksi, *impairment of vision and hearing, taste, smell, convalescence*, gangguan pancaindera, komunikasi, penyembuhan, dan kulit, sulit buang air besar, isolation, depresi, kurang gizi, insomnia (gangguan tidur), immune deficiency (daya tahan tubuh yang menurun), impotence (impotensi).

Secara umum permasalahan pada lansia terjadinya gangguan sistem penginderaan, system caridopulmonal system musculoskeletal maupun system nervorum. Seperti halnya yang disampaikan Sunaryo et.al (2016 dalam Utami, 2024) menyatakan bahwa gangguan musculoskeletal dapat menyebabkan gangguan mempertahankan postur tubuh, gangguan berjalan dan gangguan keseimbangan.

Sistem muskuloskeletal sendiri meliputi tulang, tulang rawan, tendon, dan jaringan ikat. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga postur tubuh dan membantu untuk bergerak. Sistem muskuloskeletal dapat mengalami gangguan yang dikenal sebagai gangguan muskuloskeletal. Menurut Lenak et.al (2024 dalam Utami, & Tyas, 2024) Salah satu perubahan fisik yaitu pada sistem muskuloskeletal mencakup penurunan elastisitas dan kekuatan gerak pada otot dan sendi. Gangguan pada muskuloskeletal akan memiliki potensi terganggunya fungsi gerak akibat kekakuan otot dan kekakuan di daerah persendian yang diakibatkan penurunan elastisitas dan kekuatan gerak otot dan sendi serta kemungkinan lansia jatuh sampai terjadinya

patah tulang serta dapat menyebabkan meningkatnya kematian memiliki resiko lebih besar dibandingkan usia reproduktif.

Lansia yang mengeluh tidak dapat berdiri tegak merupakan salah satu gejala yang sering dikeluhkan lansia. Ketidakmampuan berdiri tegak ini dapat disebabkan karena adanya penurunan massa otot dan tulang yang mengakibatkan penurunan keseimbangan pada orang lanjut usia, serta meningkatkan risiko kejadian jatuh (Handayani, Sari, and Wibisono 2020).

Sedangkan keluhan kekakuan tubuh pada lansia menurut Kemenkes (2019) menyebabkan lansia sering berada di tempat tidur. Keluhan kekakuan ini menurut BKKBN (2021) dapat diatasi dengan melakukan aktivitas fisik. Dengan melakukan aktivitas fisik maka diharapkan tubuh menjadi lentur. Sedangkan kelenturan tubuh adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerak melalui gerak sendi atau gerak tubuh secara maksimal.

Selain gangguan pada System musculoskeletal juga dijumpai gangguan pada system tubuh yang lain. Contoh gangguan system tubuh yang lain adalah gangguan psikologi antara lain mudah mengalirai kecemasan, jantung dan pembuluh darah antara lain terjadinya hipertensi, gangguan system metabolic seperti mengalami diabetes millitus, dan gangguan saraf seperti mengalami stroke.

Permasalahan kesehatan yang muncul selain gangguan pada system musculoskeletal beberapa diantaranya dapat diatasi dan dikelola dengan aktivitas fisik agar gangguan system organ tersebut tidak menjadi lebih buruk kondisinya. Penyakit yang dapat dicegah agar tidak menjadi semakin buruk kondisinya adalah hipertensi, diabetes mellitus, stroke maupun penyakit jantung.

Dengan adanya potensi gangguan pada lansia tersebut maka fungsi keluarga dalam keluarga lansia sangat dibutuhkan. Dengan adanya dukungan keluarga diharapkan lansia dapat mengatasidan mengambil sikap terhadap permasalahan perubahan fisik dan fungsi tubuh yang dialami lansia.

C. Dukungan Keluarga Terhadap Kesehatan Lansia

Lansia diharapkan sehat, aktif, mandiri serta produktif dalam hidupnya. Meskipun seseorang sudah memasuki masa lansia akan menghadapi keterbatasan dan ketidakmampuan yang disebabkan kualitas hidup yang mulai menurun seiring berjalannya usia.

Agar lansia dapat tetap sehat, aktif, mandiri dan produktif dalam hidupnya maka lansia membutuhkan dukungan baik dari keluarga maupun dalam komunitas. Dukungan keluarga erat kaitannya dengan kesejahteraan dan kualitas hidup lansia. Menurut Tirtarisanti (2024) bahwa indikator kesejahteraan dan kualitas hidup lansia akan secara bersama-sama nampak dari kondisi fisik, kondisi psikologis maupun hubungan social lansia. Apabila kualitas hidup lansia tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan menurunnya harapan hidup pada lansia, meningkatnya angka kesakitan bahkan kan meningkatkan angka kematian pula. Demikian juga dengan Tingkat kesejahteraan lansia juga akan menurun seiring sejalan dengan kualitas hidup lansia yang tidak terpenuhi.

Dukungan keluarga kepada lansia akan memberikan dampak pada kualitas hidup dan kesejahteraan lansia meningkat. Dan lansia akan sehat secara fisik dan mentalnya. Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Persepsi mengenai dukungan ini memberi arti bahwa keluarga siap memberikan pertolongan dan bantuan apabila diperlukan. Dukungan keluarga kepada lansia merupakan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal yang erat antar keluarga sangat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi lansia. Terdapat 4 bentuk dukungan keluarga kepada lansia baik emosional, penghargaan, informasi maupun instrumental.

Dukungan emosional nampak dari perilaku yang nampak pada lansia yang merasa dicintai dalam hidupnya. Hal ini nampak lansia tidak takut dalam melakukan suatu Tindakan karena keluarga akan mendukung secara positive dari perilaku lansia lakukan. Kasih sayang keluarga yang diberikan kepada lansia seperti berkumpul bersama dengan anggota keluarga, memberikan kesempatan lansia untuk

bersosialisasi dengan lingkungan sekitar sehingga tidak merasa bosan dan hidup berguna bagi diri sendiri dan orang lain, mengingatkan apabila lupa contohnya mengingatkan apabila meminum obat, mengingatkan untuk beraktivitas fisik misalnya berolah raga, ataupun perawatan saat lansia sakit

Dukungan penghargaan nampak dalam keluarga memberikan dukungan positive pada lansia antara lain membimbing pada hal-hal positive, mengajarkan pada hal-hal baru, maupun memberikan pujian dengan sepenuh hati. Memberikan pujian dan dorongan untuk motivasi lansia agar mampu beraktivitas fisik secara mandiri, misalnya melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri.

Dukungan informasi kepada lansia berkaitan dengan informasi yang diberikan berkaitan dengan informasi yang diperoleh lansia sehingga lansia tidak merasa terbuang atau tersisihkan dan mendorong lansia untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi lansia setelah mendapatkan informasi yang diperoleh dari keluarga. Informasi kesehatan kepada lansia akan menambah wawasan pada lansia dan mendorong lansia melakukan aktivitas fisik setelah mendapatkan informasi kesehatan dapat membantu lansia untuk menjaga kesehatan fisik dan terhindar dari masalah penyakit serius dan disabilitas. Serta lansia mampu menyadari fisik sehat maka lansia akan percaya diri. Selain itu dengan bertambahnya wawasan , lansia memahami bahwa dengan melakukan aktivitas fisik maka dapat memperlambat terjadinya gejala demensia alias pikun, mengontrol berat badan, menjaga ketahanan tulang dan otot, serta meningkatkan kualitas tidur

Sedangkan dukungan instrumental berkaitan dengan fasilitas yang digunakan lansia dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya dukungan-dukungan tersebut maka keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan lansia sebagai mencapai tujuan agar kualitas hidup lansia meningkat. Dengan adanya dukungan keluarga maka diharapkan lansia akan mendapatkan motivasi untuk beraktifitas sehingga jauh dari rasa tersingkir maupun kesepian (Tirtarisanti, 2024).

Keluarga merupakan tempat berlindung lansia yang paling disukai. Dengan adanya dukungan keluarga maka menjadikan keluarga mampu berfungsi. Fungsi keluarga adalah memberikan perawatan kepada lansia (*caregiver*). Fungsi keluarga yang mampu meningkatkan kualitas hidup lansia merupakan keluarga yang sehat. Dengan kata lain pengaruh keluarga yang sehat akan memberikan dampak yang positive pada lansia. Salah satu contoh dampak positive adalah lansia kembali termotivasi untuk rutin melakukan aktivitas fisik dalam bentuk semangat untuk melakukan olah raga kembali, sehat, mandiri, aktif dan produktif.

D. Aktifitas Fisik dan Pentingnya Aktivitas Fisik pada Lansia

Proses penuaan yang dialami lansia dapat ditunda dengan melakukan aktivitas fisik. Salah satu dampak dari proses penuaan pada lansia adalah kekakuan otot akibat penurunan elastisitas pada lansia dapat diatasi dengan melakukan aktivitas fisik. Kekakuan otot yang terjadi pada lansia disebabkan karena ruang gerak persendian terjadi penurunan sehingga tubuh tidak dapat bergerak secara maksimal Kemenkes (2019 dalam Utami dan Tyas, 2024). Kekakuan otot pada lansia dapat diatasi dengan aktivitas fisik

Aktifitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran energi atau tenaga. Contoh dari aktifitas fisik adalah berkebun, menyapu, rekreasi dan masih banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh lansia. Sementara latihan fisik merupakan suatu bentuk aktifitas fisik yang terencana, terstruktur dan berkesinambungan untuk melakukan gerakan tubuh yang berulang yang ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Contoh dari latihan fisik adalah senam, jalan cepat, berenang, dan bersepeda

Aktivitas fisik yang dilakukan oleh lansia tentunya disesuaikan dengan kondisi fisik, kebugaran dan kemampuan fisik lansia. Selain itu aktifitas fisik yang aman dapat mempertahankan mobilitas juga dapat mengurangi resiko penyakit

degenerative seperti diabetes mellitus, hipertensi, stroke, osteoporosis maupun gangguan jantung dan pembuluh darah.

Seiring bertambahnya usia. Gangguan yang sering dikeluhkan oleh lansia adalah gangguan musculoskeletal. Gangguan musculoskeletal diakibatkan kekuatan dan kepadatan otot yang menurun sehingga untuk menjaga agar gangguan musculoskeletal dihambat penurunannya, lansia perlu melakukan aktivitas fisik secara teratur.

Aktivitas fisik yang dilakukan dengan benar akan mengurangi kekakuan pada otot dan sendi-sendi tubuh terutama otot dan sendi pada anggota Gerak. Kekakuan yang sering dikeluhkan lansia adalah kesakitan pada lutut apabila digerakkan atau sulit untuk meluruskan anggota Gerak. Untuk itu manfaat aktivitas fisik dapat mengurangi dampak keluhan tersebut di atas yang bersifat fisik namun juga dapat berdampak pada psikologis serta sosial.

Aktivitas fisik secara fisik akan memberikan manfaat yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaat jangka pendek antara lain mengatur fungsi tubuh secara fisiologis. Fisiologi yang dialami tubuh adalah yang memiliki peran dalam sistem tubuh diantaranya mengatur kadar gula darah, meningkatkan kualitas tidur, semangat yang meningkat yang dipengaruhi oleh sistem kerja otak. Sedangkan manfaat jangka Panjang diharapkan aktivitas fisik pada lansia akan menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, menjaga kelenturan dan keseimbangan tubuh, mencegah dan menunda munculnya demencia.

Aktivitas fisik memiliki manfaat dari segi psikologis yang membuat lansia merasa relaks dan tenang. Dengan perasaan tenang dan relaks, stress dan gangguan kecemasan yang dialami lansia dapat menurun dan suasana hati menjadi lebih tenang. Apabila aktivitas fisik yang menyenangkan ini dilakukan secara rutin maka akan meningkatkan kesehatan mental lansia dan penurunan fungsi kognitif dapat ditunda akibat proses penuaan ini.

Aktivitas fisik memiliki manfaat dari segi sosial. Aktivitas fisik akan memberikan kepercayaan diri meningkat dan memperluas pertemanan dan jaringan sosial antar

lansia dan komunitas yang diikuti lansia. Sehingga memberikan peluang untuk saling mendorong untuk hidup sehat melalui aktivitas fisik yang sehat.

Aktivitas fisik pada lansia dilakukan secara bertahap dari intensitas ringan sampai intensitas sedang. Dalam melakukan aktivitas fisik sebaiknya pada awal lansia melakukan aktivitas fisik dipandu oleh tenaga terlatih dan dimonitor oleh tenaga kesehatan. Hal ini dikarenakan kondisi fisik lansia berbeda satu dengan yang lain.

Idealnya, lansia dianjurkan melakukan olahraga selama 150 menit per minggu, dibagi ke dalam beberapa sesi harian yang nyaman. Atau menurut kemenkes (2018) untuk latihan fisik sedang atau 17 menit untuk latihan fisik berat dalam waktu seminggu. Selain itu perlu dipastikan bahwa pada lansia durasi aktivitas fisik minimal adalah 10 menit.

Menurut Kemenkes (2024) kaidah aktivitas fisik yang baik pada lansia adalah diperhatikan frekuensi, intensitas, waktu, dan tipenya. Frekuensi sebaiknya dilakukan 3-5 kali/minggu dengan selang istirahat selama 1 hari. Apabila sudah terbiasa maka frekuensi dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan fisik lansia.

Intensitas aktivitas fisik bersifat ringan sampai sedang yang artinya denyut nadi sampai mencapai 60-70 persen denyut nadi maksimal. Atau cara lebih sederhana untuk mengetahui batas intensitas latihan adalah dengan melakukan tes bicara. Apabila saat melakukan latihan, kata-kata diucapkan dengan terengah-engah maka hal tersebut menandakan bahwa aktivitas fisik sudah melebihi intensitas yang dianjurkan.

Waktu pelaksanaan latihan aktivitas fisik yang dianjurkan adalah 30-60 menit. Tipe latihan yang dapat dilakukan pada lansia adalah latihan aerobik, latihan kekuatan, serta latihan keseimbangan dan kelenturan.

Latihan Aerobik dapat meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, serta melatih daya tahan tubuh. Aktivitas fisik kategori aerobik adalah jalan kaki, bersepeda santai dan berenang. Jalan kaki adalah aktivitas yang sudah dilakukan dan efektif meningkatkan sirkulasi darah berdampak pada peredaran oksigen ke seluruh

tubuh. Sedangkan bersepeda santai sangat baik untuk melatih otot terutama otot kaki dan meningkatkan kemampuan pembuluh darah dan jantung. Sedangkan renang merupakan aktivitas fisik yang aman bagi lansia dengan masalah sendi.

Latihan kekuatan otot akan mencegah penurunan massa otot dan meningkatkan metabolisme. Contoh Latihan kekuatan otot adalah dengan beban ringan seperti dumbbell, aktivitas sehari-hari seperti naik turun tangga secara perlahan.

Latihan kelenturan atau fleksibilitas dapat meningkatkan kelenturan tubuh dan mencegah kekakuan sendi. Karena pada lansia telah terjadi penurunan elastisitas pada sendi. Contoh Latihan untuk meningkatkan kelenturan antara lain adalah Yoga maupun peregangan ringan (Kemenkes 2024). Yoga dapat membantu meningkatkan fleksibilitas/kelenturan tubuh, keseimbangan dan relaksasi.

Latihan keseimbangan sangat penting untuk mencegah resiko jatuh. Resiko jatuh merupakan masalah yang sering menjadi permasalahan pada lansia. Gerakan untuk melatih keseimbangan pada lansia antara lain dengan berdiri dengan satu kaki secara bergantian, latihan ini untuk melatih kekuatan otot. Latihan ini dilakukan dengan rutin dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Selain itu Latihan keseimbangan dapat dilakukan dengan berjalan dan saat berjalan tumit menyentuh jari kaki yang lain, Latihan ini melatih kestabilan tubuh. Sedangkan Latihan mengangkat kaki kebelakang memiliki fungsi memperkuat otot tulang belakang dan otot bagian pantat. Latihan berjinjit memiliki fungsi untuk memperkuat otot pada kaki, betis dan pergelangan kaki (Kemenkes, 2018).

Latihan keseimbangan juga dapat dilakukan dengan cara berjalan kesamping dan push up di dinding. Kedua aktivitas fisik ini akan meningkatkan kekuatan otot dan system koordinasi otak.

Aktivitas fisik bagi lansia secara umum akan meningkatkan kebugaran, mempertahankan mobilitas, mengurangi resiko penyakit, meningkatkan kesehatan mental maupun memperbaiki keseimbangan. Pada saat tubuh memiliki kebugaran yang optimal maka fungsi jantung dan paru serta otot akan terjaga dengan baik.

Selain itu dengan beraktivitas fisik maka sendi dan otot akan terlatih untuk dapat bergerak dengan lebih mudah. Selain itu resiko penyakit seperti kadar gula darah, tekanan darah dan kolesterol akan menurun dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin. Manfaat yang lain adalah dapat mencegah resiko jatuh yang dapat berakibat cidera. Dan dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin dapat mengurangi stress, maupun depresi dan kecemasan, hal ini dikarenakan pada saat beraktivitas fisik akan mengeluarkan hormon endorphen. Di mana hormon endorphen memiliki dampak tubuh menjadi tenang, tidak cemas serta mengurangi stres (Kemenkes, 2018).

Dengan mengetahui jenis dan manfaat aktivitas fisik, lansia dengan dukungan keluarga dapat melakukan aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan kesehatan lansia.

E. Keamanan dan Kenyamanan Dalam Beraktivitas Fisik Pada Lansia

Lansia dengan beranjaknya usia tentunya akan mengalami keterbatasan fisik dalam melakukan aktivitas fisik. Hal ini dikarenakan struktur dan fungsi tubuh yang sudah mengalami penurunan secara alamiah. Namun keterbatasan ini tidak hanya dikarenakan struktur dan fungsi tubuh yang menurun tetapi juga dijumpai penyakit yang menyertai lansia yang akan menambah keterbatasan hidup lansia.

Untuk meningkatkan kualitas hidup pada lansia, Dengan adanya keterbatasan ini, lansia tetap dapat melakukan aktivitas fisik. Namun aktivitas fisik yang dilakukan tentunya diperlukan keamanan dan kenyamanan untuk lansia.

Keamanan aktivitas fisik bagi lansia tidak lepas dari nyaman lansia pada saat melakukan aktivitas fisik. Keamanan dapat berasal dari dalam maupun dari luar. Keamanan dari dalam artinya lansia mengenal kemampuan diri sehingga aktivitas fisik dilakukan sesuai kemampuan dan tidak berlebihan. Sedangkan keamanan beraktivitas fisik dari luar adalah keamanan yang berasal dari luar ruangan. Salah satu diantaranya adalah melakukan aktivitas fisik pada saat siang hari hal ini mengurangi resiko terjatuh dikarenakan tidak dapat melihat dengan jelas dan mengurangi resiko melewati permukaan tanah yang tidak rata

Selain keamanan juga kenyamanan bagi lansia. Untuk meningkatkan kenyamanan lansia saat latihan fisik diantaranya lansia sebaiknya menggunakan pakaian yang longgar dan nyaman serta alas kaki yang sesuai. Lakukan latihan fisik sesuai toleransi, jangan memaksakan diri. Lakukan pemanasan sebelum melakukan latihan fisik untuk mengurangi resiko cedera. Lakukan pemanasan sebelum olahraga dan pendinginan setelahnya. Menggunakan perlengkapan yang nyaman, seperti sepatu olahraga yang mendukung

Dengan menerapkan aktivitas fisik yang sesuai, lansia dapat mempertahankan kesehatan fisik dan mental, meningkatkan kualitas hidup, serta menjalani masa tua dengan lebih aktif dan produktif. Dukungan keluarga dan komunitas juga dapat memotivasi lansia untuk tetap aktif secara fisik

F. Penutup

Setiap lansia pasti akan mengalami penurunan struktur dan fungsi tubuh. Hal ini dikarenakan menurunnya kemampuan jaringan tubuh untuk mempertahankan kerusakan jaringan yang dialami oleh tubuh. Untuk itu aktivitas fisik diharapkan dapat menunda kerusakan jaringan secara progresif dan massif.

Adanya dukungan keluarga baik berupa dukungan emosi, dukungan penghargaan dukungan informasi dan dukungan instrumental dapat menguatkan motivasi lansia untuk berjuang sehat dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin

Aktivitas fisik pada lansia disesuaikan dengan kemampuan lansia yang aman dan sesuai sangat penting bagi lansia untuk meningkatkan kebugaran, mempertahankan mobilitas, serta mengurangi risiko penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dan osteoporosis.

Keberhasilan lansia dalam melakukan aktivitas fisik maka diharapkan lansia sehat, aktif, mandiri serta produktif dalam hidupnya

Referensi

- Astuti, E., Sari, E., & Pradana, V. (2024). Dukungan Keluarga Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Gereja St. Petrus Balung Jember. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 1-8. <https://doi.org/10.47560/kep.v13i1.600>
- BKKBN. (2019) Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia. Jakarta
- BKKBN. (2021) Masalah yang sedang dihadapi Lansia Tangguh. tersedia dalam <https://golantang.bkkbn.go.id/masalah-yang-sering-dihadapi-oleh-lansia>
- BKKBN (2024). Delapan Fungsi Keluarga. tersedia dalam <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/54206/intervensi/980050/delapan-fungsi-keluarga>
- Darmawanti, B. (2022). <https://ayosehat.kemkes.go.id/cara-tepat-menjaga-kebugaran-fisik-bagi-lansia>
- Handayani, S. P., Sari, R. P., & Wibisono, W. (2020). Literature Review Manfaat Senam Lansia Terhadap Kualitas Hidup Lansia. *Bimiki (Berkala Ilmiah Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia)*, 8(2), 48–55. <https://doi.org/10.53345/Bimiki.V8i2.143>
- Kemenkes (2019) <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/hipertensi-penyakit-jantung-dan-pembuluh-darah/latihan-fisik-dapat-meningkatkan-kelenturan-tubuh>
- Kemenkes (2019). Indonesia memasuki periode aging population. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20190704/4530734/indonesia-masuki-periode-aging-population/>
- Kemenkes. (2024) AKTIVITAS-FISIK-UNTUK-MENJAGA-KEBUGARAN-LANSIA
- Masril, B. A., Sari, N. P., & Natassa, J. (2022). "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Keaktifan Lansia (Active Aging) di Puskesmas Payung Sekaki Kota Pekanbaru". *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 8(2), 333–343. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol8.iss2.1034>

- Martina, S. E., Gultom, R., Sinaga, J. dan Keren (2023). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kemandirian Lansia Dalam Aktivitas Sehari-Hari Di Desa Suka Makmur Kabupaten Langkat. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 6 No.4, 2023. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Sari, N.R, Nugroho, S.W., Sulistyowati, R., Agustina, R., Yulianto, K.T., dan Anggraeni,G. (2024) Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024. Direktorat Badan Pusat Statistik. volume 21, 2024. Jakarta
- Subekti, K. E. & Dewi, S. (2022) Dukungan Keluarga Berhubungan dengan TIngkat Kulaitas Hidup Lansia. *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*. Volume 10 No 2 Hal 403 - 410, Mei 2022, e-ISSN 2655-8106, p-ISSN2338-2090. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKJ/article/view/9703/pdf>
- Syarbini, A. 2016. Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Studi Tentang Model Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam.Jogjakarta : AR-RUZZ Media
- Tirtarisanti, N. (2024) Dukungan Keluarga Sebagai Support System Bagi Lansia. BKKBN. tersedia dalam <https://golantang.bkkbn.go.id/upload/artikel/pdf/1142-dukungan-keluarga-sebagai-support-system-bagi-lansia.pdf>
- Utami, J.N.W. (2024) "Analysis of Menopause and History Falls on Body Balance Disorders of Elderly Cadres in Munggon Villages, Berbah, and Ngajeg Villages, Kalasan, Sleman Regency" Vol. 1 No. 1 (2024): Proceedings of International Joint Seminar 2023. tersedia pada : <https://proceeding.lsmsharing.com/index.php/event/issue/view/2>
- Utami, J. N. W & Nurtyas. W. (2024) "Relationship Between Gender, Age, and BMI with Body Flexibility at MAN 2, Sleman, Yogyakarta" *International Journal of Natural and Health Sciences (IJNHS)*Vol.2,No.3,2024:225-232. Tersedia pada: <https://doi.org/10.59890/ijnhs.v2i3.2301>
- Utami, J.N.W., Nurtyas, M., Wulandari, S., Andriani, G., (2024) "Relationship Between

Gender, Age, and BMI with Body Flexibility at MAN 2, Sleman, Yogyakarta”
International Journal of Natural and Health Sciences (IJNHS) Vol.2, No.3, 2024:
233-242. Tersedia pada: DOI: <https://doi.org/10.59890/ijnhs.v2i3.2303>

Glosarium

A

AAA: adalah

B

BBB: adalah

C

CCC: adalah

BAB V

PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM MEMBERIKAN PANDUAN OLAHRAGA LANSIA

A. Pendahuluan

Olahraga, terutama bagi lansia, sangat penting untuk kesehatan dan kualitas hidup. Kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik dipengaruhi oleh berbagai perubahan fisik dan fungsional yang terjadi seiring bertambahnya usia. Lansia sering mengalami penurunan kekuatan otot, fleksibilitas, keseimbangan, dan kesehatan jantung. Oleh karena itu, olahraga yang sesuai dengan kesehatan mereka sangat penting untuk tetap sehat, menghindari penyakit, dan menikmati hidup yang lebih baik. Tenaga kesehatan sangat penting dalam hal ini untuk memberikan pedoman olahraga yang aman dan berhasil.

Orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, seperti dokter, fisioterapis, pelatih olahraga, dan ahli gizi, bertanggung jawab untuk mengembangkan program olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Mereka tidak hanya berusaha mencegah penyakit, tetapi juga membantu lansia tetap aktif, mandiri, dan menikmati kehidupan sehari-hari tanpa kesulitan fisik. Dengan program olahraga yang tepat, lansia dapat memperkuat jantung mereka, memperkuat otot dan tulang mereka, dan mengembalikan keseimbangan dan koordinasi tubuh mereka. Olahraga juga terbukti dapat meningkatkan mood, mengurangi risiko jatuh, dan memperbaiki kualitas tidur, yang sering terganggu pada usia lanjut.

Tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan panduan olahraga dengan menilai kondisi fisik lansia, mengubah jenis dan intensitas olahraga, dan memantau lansia secara teratur untuk menghindari cedera. Untuk memastikan bahwa lansia dapat berolahraga tanpa mengancam kesehatan mereka, mereka biasanya akan diperiksa oleh dokter atau tenaga medis lainnya. Pelatih olahraga terlatih atau fisioterapis akan membuat latihan yang sesuai dengan kemampuan fisik

lansia. Mereka juga akan memberikan instruksi yang jelas tentang cara melakukan gerakan tertentu dengan aman.

Studi terbaru menunjukkan bahwa olahraga yang terstruktur, seperti aerobik, kekuatan, dan keseimbangan, sangat membantu lansia dalam meningkatkan kesehatan fisik dan mental mereka. Sebagai contoh, penelitian dari American College of Sports Medicine (2022) menemukan bahwa latihan aerobik dengan intensitas rendah hingga sedang dapat meningkatkan kapasitas kardiorespirasi lansia, mengurangi risiko penyakit jantung, dan meningkatkan kemampuan kognitif. Sebaliknya, massa otot, kekuatan tulang, dan mobilitas fisik pada lansia juga dapat ditingkatkan melalui latihan kekuatan, juga dikenal sebagai latihan kekuatan (Loenneke et al., 2021).

B. Tenaga Kesehatan

1. Definisi Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri kepada kesehatan dan memiliki profesionalisme, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan kesehatan.

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, karyawan dimasukkan ke dalam berbagai kategori, seperti: staf psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, terapi fisik, teknik medis, biomedika, dan kesehatan tradisional.

2. Tugas Utama Tenaga Kesehatan

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, undang-undang yang mengatur fungsi utama tenaga kesehatan di Indonesia telah mengalami perubahan besar. Undang-undang ini mencabut dan menggantikan beberapa undang-undang sebelumnya, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Berikut adalah beberapa tanggung jawab utama yang dilakukan oleh tenaga kesehatan:

- a. **Pelayanan Promotif:** Usaha untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan individu melalui penyuluhan dan promosi kesehatan.
- b. **Pelayanan Pencegahan:** Tindakan untuk mencegah penyakit, seperti vaksinasi dan skrining kesehatan.
- c. **Pelayanan Kuratif:** Pengobatan dan perawatan yang diberikan kepada orang yang sakit untuk membantu mereka pulih.
- d. **Pelayanan Rehabilitatif:** Upaya untuk membantu pasien pulih dari penyakit atau cedera agar mereka dapat berfungsi dengan baik kembali.

Selain itu, tenaga kesehatan juga memiliki kewajiban untuk:

- a. **Memberi Pelayanan yang Aman dan Berkualitas:** Tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional yang berlaku.
- b. **Menghormati Hak Pasien:** Tenaga medis harus menghormati hak pasien, termasuk hak atas informasi, privasi, dan persetujuan untuk tindakan medis.
- c. **Melakukan Pencatatan dan Pelaporan:** Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pelaporan.
- d. **Mengikuti Pengembangan Kompetensi:** Tenaga kesehatan harus mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya.

C. Olahraga Lansia

Definisi olahraga:

Berbagai sumber menegaskan bahwa definisi "olahraga" merujuk pada aktivitas fisik yang dirancang dan direncanakan dengan tujuan meningkatkan kebugaran jasmani, kesehatan mental, dan kesejahteraan seseorang. Gerakan tubuh yang teratur sendiri dan manfaatnya bagi kesehatan sangat penting.

Beberapa sumber ahli mengatakan bahwa olahraga adalah:

- 1) Hans Tandra: Olahraga adalah gerakan tubuh teratur dengan irama yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kebugaran dan kekebalan tubuh (Tandra, 2023).
- 2) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mendefinisikan olahraga sebagai setiap kegiatan fisik yang dilandasi semangat perjuangan melawan alam, orang lain, atau diri sendiri dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup (KONI, 2023).
- 3) Olahraga, menurut Yandianto (2000:391), adalah aktivitas fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kesejahteraan fisik (Yandianto, 2000).

1. Manfaat olahraga:

Melalui berbagai manfaat yang ada, olahraga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Berikut adalah beberapa manfaat utama olahraga:

- a. **Meningkatkan Kesehatan Jantung:** Berolahraga secara teratur dapat membantu jantung, paru-paru, dan pembuluh darah lebih baik, yang membantu mencegah penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan stroke.
- b. **Meningkatkan Kesehatan Mental:** Berolahraga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan fungsi kognitif, dan mengurangi depresi dan kecemasan.
- c. **Meningkatkan Fleksibilitas dan Sirkulasi Darah:** Olahraga memperlancar metabolisme tubuh, meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas otot, dan meningkatkan sirkulasi darah.
- d. **Mencegah Penyakit Degeneratif:** Berolahraga dapat memperkuat otot jantung, meningkatkan kapasitas jantung, dan menurunkan risiko penyakit degeneratif (Wicaksono, 2021).

2. Manfaat olahraga bagi Lansia:

Jika dilakukan secara teratur, olahraga dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup lansia. Berikut adalah beberapa keuntungan utama olahraga bagi lansia:

- a. **Meningkatkan Kesehatan Jantung:** Berolahraga dapat memperkuat otot jantung, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular (Angga, 2010).
- b. **Memperkuat Otot dan Tulang:** Kekuatan otot, kepadatan tulang, dan keseimbangan yang lebih baik dapat dicapai melalui latihan beban. Ketiga hal ini sangat penting untuk menjaga kemandirian dan kualitas hidup pada usia lanjut.
- c. **Meningkatkan Fungsi Kognitif:** Latihan aerobik dengan intensitas ringan hingga sedang dapat meningkatkan fungsi kognitif lansia, membantu mencegah penurunan daya ingat dan demensia (Listyasari, 2019).
- d. **Meningkatkan Kesehatan Mental:** Olahraga dapat mengurangi risiko depresi, meningkatkan suasana hati, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketergantungan pada orang lain (Sucipto, 2023).
- e. **Memperbaiki Kualitas Hidup:** Berolahraga membantu lansia menjadi lebih mandiri, menghindari obesitas, dan lebih percaya diri, sehingga mereka lebih baik secara keseluruhan (Farizati, 2020).

3. Olahraga untuk Lansia:

Melakukan olahraga secara teratur sangat penting untuk kesehatan dan kualitas hidup lansia. Berikut adalah beberapa jenis olahraga yang disarankan untuk lansia dan alasan mengapa mereka direkomendasikan:

- a. **Berjalan Kaki:** Berjalan kaki adalah olahraga sederhana yang dapat meningkatkan kesehatan jantung, menguatkan otot, dan menjaga keseimbangan tubuh. Lansia disarankan untuk berjalan kaki selama dua puluh hingga tiga puluh menit setiap hari.

- b. **Bersepeda:** Bersepeda secara santai meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi risiko penyakit jantung, dan melatih otot kaki. Pilih jalur yang aman dan nyaman (RS Elizabeth, 2025).
- c. **Berenang:** Berenang meningkatkan kekuatan otot dan sendi dan meningkatkan aliran darah, yang baik untuk jantung, otak, dan paru-paru (Alodokter, 2023).
- d. **Yoga dan Tai Chi** adalah olahraga yang berfokus pada pernapasan, keseimbangan, dan fleksibilitas, sehingga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan keseimbangan tubuh, dan mengurangi risiko jatuh (RS Pondok Indah, 2024)
- e. **Senam Lansia:** Latihan yang dimaksudkan untuk orang yang lebih tua untuk mempertahankan kebugaran tubuh mereka dengan menggunakan gerakan yang lembut dan terkontrol yang meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan (RS Elizabeth, 2025).
- f. **Latihan Keseimbangan:** Latihan seperti berdiri di atas satu kaki atau berjalan jinjit sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjatuh.
- g. **Pilates:** Latihan ini meningkatkan keseimbangan tubuh, kekuatan otot, dan energi.
- h. **Dansa:** Melakukan gerakan dansa dengan musik dapat membantu lansia tetap bugar dan seimbang, dan itu juga dapat membantu lansia lebih banyak berinteraksi dengan orang lain (Alodokter, 2023).

4. Frekuensi dan Durasi

- a. **Latihan Aerobik:** seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda yang meningkatkan detak jantung dan pernapasan. Latihan ini membantu meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Disarankan untuk melakukan latihan dengan intensitas sedang selama tiga puluh menit setiap sesi, setidaknya lima hari setiap minggu, atau dua puluh menit dengan intensitas tinggi sebanyak tiga hari setiap minggu.

- b. **Latihan untuk menguatkan otot** harus dilakukan setidaknya dua hari setiap minggu, dengan istirahat untuk masing-masing kelompok otot di antara sesi.
- c. **Latihan untuk Fleksibilitas dan Keseimbangan:** Untuk fleksibilitas, disarankan 2-3 hari per minggu, dan untuk keseimbangan, setidaknya 3 hari per minggu (Mega, H, dkk. 2024).

5. Pertimbangan Keselamatan

- a. **Konsultasi Medis:** Lansia harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum memulai program olahraga untuk menyesuaikan jenis dan intensitas latihan sesuai dengan kondisi kesehatan mereka.
- b. **Peningkatan Bertahap:** Untuk menghindari cedera, mulailah dengan intensitas yang rendah dan tingkatkan secara bertahap.
- c. **Lingkungan Aman:** Pastikan tempat latihan adalah aman dan tidak ada hal-hal yang dapat menyebabkan jatuh (Mega, H, dkk. 2024).

6. Hambatan olahraga pada lansia

Lansia sering menghadapi berbagai kesulitan saat berolahraga, yang dapat mempengaruhi keterlibatan mereka dalam olahraga. Berikut adalah beberapa hambatan utama yang sering terjadi pada lansia:

- a. **Penurunan Kondisi Fisik:** Dengan bertambahnya usia, proses penuaan alami menyebabkan penurunan massa otot, perubahan distribusi darah ke otot, dan peningkatan kekakuan otot. Akibatnya, orang yang lebih tua mungkin tidak dapat melakukan olahraga dengan baik (Mega, H, dkk. 2024).
- b. **Kurangnya Motivasi dan Dukungan Sosial:** Beberapa lansia mungkin tidak termotivasi untuk berolahraga, terutama jika mereka tidak memiliki dukungan dari keluarga atau komunitas mereka. Namun, penelitian menunjukkan bahwa hambatan-hambatan ini tidak selalu menyebabkan lansia berhenti berolahraga (Ernawati & Triyana, H, 2022).

- c. **Keterbatasan Pengetahuan tentang Manfaat Olahraga:** Lansia mungkin tidak tahu bagaimana melakukan olahraga atau bagaimana melakukannya dengan aman (Ernawati & Triyana, H, 2022).
- d. **Kondisi Kesehatan dan Penyakit Kronis:** Lansia dengan penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, dan masalah jantung mungkin ragu untuk berolahraga karena takut kondisi mereka akan memburuk (Maghfiroh, dkk, 2024).
- e. **Faktor Psikologis:** Cemas, depresi, atau ketidakpercayaan diri dapat menghalangi orang tua untuk berolahraga (Ernawati & Triyana, H, 2022).
- f. **Keterbatasan Fasilitas dan Aksesibilitas:** Kurangnya fasilitas olahraga yang ramah lansia atau sulit mendapatkan akses ke fasilitas latihan dapat menjadi hambatan yang sangat besar (Sari, A, dkk. 2013).

D. Peran Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan Panduan Olahraga Lansia

Peran Tenaga Kesehatan dalam Memberikan Panduan Olahraga Lansia

Tenaga kesehatan sangat penting dalam memberikan panduan olahraga bagi lansia agar mereka lebih sehat dan menikmati kualitas hidup mereka. Berikut adalah beberapa peran utama tenaga kesehatan dalam memberikan panduan olahraga pada Lansia:

1. **Memberi Konseling dan Dukungan:** Tenaga kesehatan, seperti dokter atau ahli gizi, bertanggung jawab untuk memberi panduan, mendorong, dan mendukung lansia untuk lebih banyak berolahraga (Muh. Ihsan, 2023).
2. **Menyediakan Fasilitas dan Aksesibilitas:** Memberikan fasilitas olahraga yang sesuai dan mudah diakses untuk lansia dapat membantu mereka lebih terlibat dalam aktivitas fisik (Wahyu, E, dkk. 2014).
3. **Menyelenggarakan Program Latihan Terstruktur:** Penderita hipertensi dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan senam lansia (Permata, R & Neini, R, 2023).

4. **Meningkatkan Kesadaran dan Edukasi:** Tenaga kesehatan dapat mendorong lansia untuk berpartisipasi lebih aktif dalam program kesehatan seperti posyandu (Awaludin, 2025).

E. Penutup

Sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk memberikan panduan olahraga bagi lanjut usia untuk memastikan bahwa olahraga aman, efektif, dan sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Dengan bimbingan yang tepat, lanjut usia dapat menikmati banyak manfaat olahraga, termasuk peningkatan keseimbangan, kekuatan, fleksibilitas, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Oleh karena itu, untuk membuat program olahraga yang berkelanjutan dan menyenangkan, tenaga kesehatan, keluarga, dan lansia sendiri harus bekerja sama. Dengan menggunakan pendekatan yang holistik dan berbasis bukti, diharapkan lansia dapat tetap aktif, mandiri, dan sehat di usia senja.

Referensi

- Angga, D. (2010). Pentingnya Olahraga Bagi Kesehatan Lansia. BKKBN Golantang.
- Alodokter. (2023). Berbagai Jenis Olahraga untuk Lansia Beserta Manfaatnya.
- American College of Sports Medicine. (2022). *Physical Activity Guidelines for Older Adults*. ACSM.
- Awaludin, dkk. (2025). Hubungan dukungan tenaga kesehatan dan peran kader dengan keaktifan lansia mengikuti posyandu lansia di desa ranupakis kecamatan klakah. *Jurnal Keperawatan*. Vol 16, No 1, Hal. 20-29.
- Ernawati & Triyana, H. (2022). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Motivasi Lansia Berpartisipasi di Program Olahraga Rutin Posyandu Lansia Permata. *Faletehan Health Journal*. 9 (1), 43-50.
- Farizati, N. (2020). Manfaat Olahraga pada Lansia. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 5(2), 95-102.
- Komite Olahraga Nasional Indonesia. (2023). *Pedoman Dasar Keolahragaan Nasional*. Jakarta: KONI Pusat.
- Listyasari, N. (2019). Latihan Aerobik dan Fungsi Kognitif pada Lansia. *JUARA: Jurnal Olahraga*, 4(2), 123-130.
- Loenneke, J. P., et al. (2021). The Effects of Resistance Training on Muscle Mass, Strength, and Functional Capacity in Older Adults. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 35(8), 2195-2205.
- Maghfiroh, R, dkk. (2024). Hubungan Kebiasaan Olahraga Dengan Kualitas Hidup Lansia Puskesmas Menganti. *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Vol 4, No 2, Hal. 1-7.
- Mega, H, dkk. (2024). *Modul Digital Kesehatan Olahraga*. Program Studi Gizi, fakultas Pendidikan dan Olahraga Kesehatan, Univeristas Pendidikan Indonesia.
- Muh. Ihsan. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Keaktifan Lansia Dalam Mengikuti Senam Prolanis Pada Penderita Hipertensi. *Jurnal Edukasi Ilmiah Kesehatan*. Vol 1, No 2, Hal. 85-91.
- Permata, R & Neini, R. (2023). Efektivitas Senam Lanjut Usia pada Penurunan Tekanan Darah Penderita Hipertensi. *Jurnal Ilmu Kesehatan*. Vol 6, No 1, Hal. 109-114.
- RS Elizabeth. (2025). Olahraga yang Dianjurkan untuk Lansia agar Tetap Sehat dan Bugar.
- RS Pondok Indah. (2024). 6 Olahraga untuk Lansia yang Mudah Dilakukan.
- Sari, A, dkk. (2013). Tantangan dan Hambatan Program Pengembangan Kesehatan Olahraga untuk Lansia di Puskesmas Kota Manado. *Jurnal Kedokteran dan Komunitas dan Tropik*. Vol 1, No 3, Hal. 113-119.

- Sucipto, A., & Hardinoto, M. (2023). Hubungan Kebiasaan Olahraga dengan Kualitas Hidup Lansia. *Jurnal Corner*, 9(1), 45-52.
- Tandra, H. (2023). *Panduan Kebugaran dan Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Kesehatan Sehat.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Wahyu, E, dkk. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi lansia melakukan olah raga senam lansia di panti sosial lanjut usia (pslu) kabupaten Mojokerto. *Jurnal Metabolisme*. Vol 3, No 1, Hal. 1-7.
- Wicaksono, A., & Handoko, W. (2021). *Aktivitas Fisik dan Kesehatan*. ResearchGate.
- Yandianto. (2000). *Dasar-dasar Olahraga untuk Kebugaran*. Bandung: Penerbit Olahraga Jaya.

Glosarium

K

KONI: adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia

L

Lansia: adalah Lanjut Usia

P

Posyandu: adalah Pos Pelayanan Terpadu

Profil Penulis

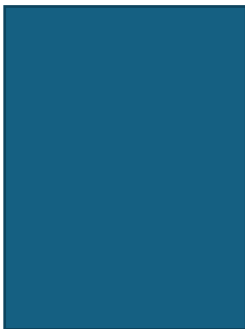


Fatimah, S.Kp., M.Kep., Ns.Sp.Kep.Kom.

Lahir di Jakarta, 01 Juni 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Indonesia tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus tahun 2015. Penulis selanjutnya mengambil program Perawat Spesialis Komunitas di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996 di RSPAD

Gatot Soebroto sebagai pembimbing klinik, lalu mengikuti program traineeship bidang keperawatan lansia di Belanda sampai 1998. Saat ini penulis bekerja di Universitas Mohammad Husni Thamrin mengampu mata kuliah keperawatan komunitas, keluarga, dan gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fatimahsap01@gmail.com

Motto: "Allah memberi kita peran terbaik, maka berperanlah sebaik mungkin"



Gina Fazrina, Str. Ftr., MKM.

Lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 23 Januari 1992. Saya merupakan lulusan Diploma Tiga Fisioterapi Universitas Indonesia dan Sarjana Terapan Fisioterapi Universitas Binawan Jakarta. Pada tahun 2021, saya mendapatkan Beasiswa Pendidikan Indonesia, program beasiswa dari pemerintah Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), untuk menempuh Magister Kesehatan

Masyarakat Peminatan Epidemiologi di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Saya bekerja sebagai klinisi di rumah sakit dan praktik klinik, serta mengajar sejak 2015 dengan peminatan Terapi Latihan dan Fisioterapi Olahraga. Saya tergabung dalam kepengurusan organisasi profesi Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Cirebon sebagai bidang pengembangan mutu dan diklat.



Dr. Nunuk Sri Purwanti, S.Kp., M.Kes.

Lahir di Klaten, 28 Pebruari 1967. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia, lulus tahun 1993. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2004. Sedangkan Pendidikan S3 pada Program Studi Doktorat Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, FK-KMK Universitas Gadjah Mada yang diselesaikan pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1994 sebagai pendidik di Sekolah Perawat Kesehatan, Departemen Kesehatan RI. Kemudian sejak tahun 2001 sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta di Jurusan Keperawatan. Saat ini penulis bekerja sebagai pengampu mata kuliah keperawatan komunitas, keperawatan kelompok khusus, keperawatan keluargadan keperawatan gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nunuksripurwanti@gmail.com. Motto: "Living your life well"



dr. Jacoba Nugrahaningtyas Wahjuning Utami, M. Kes.

Lahir di Yogyakarta. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 1994. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2000. Riwayat pekerjaan sebagai dosen diawali pada tahun 2014 sampai sekarang. Selain sebagai dosen penulis juga bekerja sebagai dokter di UKS SMKN 6 Yogyakarta dari tahun 1999-sekarang dan bekerja di salah satu klinik di Yogyakarta dari tahun 1999-sekarang. Saat ini penulis bekerja di Universitas Respati Yogyakarta mengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Etika Profesi, Promosi Kesehatan, Komunikasi Profesional, Pemeriksaan dan Pengukuran, Psikologi Kesehatan, maupun Patologi Sistem. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, maupun melakukan pengabdian masyarakat baik tingkat lokal, nasional dan internasional maupun menulis rubrik konsultasi di koran digital di Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nugrahaningtyas@respati.ac.id



Ns. Destria Efliani, S.Kep, MM

Lahir di Concong Luar, 31 Desember. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Respati Yogyakarta tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Surakarta dan lulus pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015 di Institut Kesehatan dan Teknologi Al Insyirah Pekanbaru mengampu mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan, Komunikasi Terapeutik Keperawatan dan Keperawatan Gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui email: destria.efliani@ikta.ac.id
Motto: "Living your life well"

Sinopsis

Buku referensi "Pentingnya Kebugaran Fisik pada Lansia" secara komprehensif mengupas berbagai aspek yang terkait dengan aktivitas fisik dan olahraga khusus bagi lansia. Buku ini terbagi dalam beberapa bab utama yang membahas aktivitas fisik yang aman dan efektif, pengaruh olahraga terhadap keseimbangan dan mobilitas, kolaborasi komunitas dalam menciptakan program kebugaran lansia, dukungan keluarga dalam aktivitas fisik lansia, serta peran penting tenaga kesehatan dalam memberikan panduan olahraga yang tepat.

Bab pertama menjelaskan secara detail definisi aktivitas fisik, exercise, dan olahraga yang khusus disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Bab ini juga memuat panduan intensitas aktivitas fisik yang ideal, jenis latihan yang aman, serta tips khusus untuk lansia dengan kondisi kronik dan disabilitas. Bab kedua membahas manfaat nyata olahraga dalam meningkatkan keseimbangan, mobilitas, serta kemampuan fungsional lansia, disertai dengan berbagai contoh latihan yang dapat diterapkan.

Bab ketiga memaparkan pentingnya kolaborasi komunitas dalam merancang dan melaksanakan program kebugaran lansia, menyoroti peran strategis dari institusi kesehatan, pemerintah, dan keluarga. Selanjutnya, bab keempat mengangkat peran sentral keluarga dalam mendukung aktivitas fisik lansia, yang mencakup dukungan emosional, informasi, hingga dukungan instrumental. Bab terakhir menyoroti peran tenaga kesehatan sebagai pilar utama dalam memberikan panduan olahraga yang aman, efektif, dan berbasis bukti ilmiah untuk lansia.

Buku ini ditujukan bagi lansia, keluarga, tenaga kesehatan, serta semua pihak yang terlibat dalam peningkatan kualitas hidup lansia. Dengan pendekatan yang terstruktur dan informasi yang berbasis bukti ilmiah, buku ini menjadi referensi utama dalam menciptakan lansia yang sehat, aktif, mandiri, dan produktif di usia senja mereka.

Buku referensi "Pentingnya Kebugaran Fisik pada Lansia" secara komprehensif mengupas berbagai aspek yang terkait dengan aktivitas fisik dan olahraga khusus bagi lansia. Buku ini terbagi dalam beberapa bab utama yang membahas aktivitas fisik yang aman dan efektif, pengaruh olahraga terhadap keseimbangan dan mobilitas, kolaborasi komunitas dalam menciptakan program kebugaran lansia, dukungan keluarga dalam aktivitas fisik lansia, serta peran penting tenaga kesehatan dalam memberikan panduan olahraga yang tepat.

Bab pertama menjelaskan secara detail definisi aktivitas fisik, exercise, dan olahraga yang khusus disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Bab ini juga memuat panduan intensitas aktivitas fisik yang ideal, jenis latihan yang aman, serta tips khusus untuk lansia dengan kondisi kronik dan disabilitas.

Bab kedua membahas manfaat nyata olahraga dalam meningkatkan keseimbangan, mobilitas, serta kemampuan fungsional lansia, disertai dengan berbagai contoh latihan yang dapat diterapkan.

Bab ketiga memaparkan pentingnya kolaborasi komunitas dalam merancang dan melaksanakan program kebugaran lansia, menyoroti peran strategis dari institusi kesehatan, pemerintah, dan keluarga. Selanjutnya, bab keempat mengangkat peran sentral keluarga dalam mendukung aktivitas fisik lansia, yang mencakup dukungan emosional, informasi, hingga dukungan instrumental. Bab terakhir menyoroti peran tenaga kesehatan sebagai pilar utama dalam memberikan panduan olahraga yang aman, efektif, dan berbasis bukti ilmiah untuk lansia.

Buku ini ditujukan bagi lansia, keluarga, tenaga kesehatan, serta semua pihak yang terlibat dalam peningkatan kualitas hidup lansia. Dengan pendekatan yang terstruktur dan informasi yang berbasis bukti ilmiah, buku ini menjadi referensi utama dalam menciptakan lansia yang sehat, aktif, mandiri, dan produktif di usia senja mereka.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

